Universidad Mundae

Escuela Universitaria de **Ciencias de la Salud**

Licenciatura en Enfermería

# Polimedicación psicotrópica y contención química en personas mayores institucionalizadas: la desprescripción como estrategia enfermera para proteger la calidad de vida

| | |
|---|---|
| Trabajo Final de Graduación presentado por: | El Asisa Kaddur El Founti |
| Modalidad: | Revisión narrativa (revisión bibliográfica) |
| Área de trabajo: | Salud mental y envejecimiento |
| Línea: | Impacto de la polimedicación en la calidad de vida del anciano |
| Fecha: | Noviembre de 2026 |
| Tutora: | Nuria Gracia Carrillo |

| | |
|---|---|
| Firma tutora: | Firma alumna: |

# Declaración de Autoría, Originalidad y Responsabilidad

Dña. El Asisa Kaddur El Founti, estudiante matriculada en la asignatura de Trabajo Final de Graduación del programa de Licenciatura en Enfermería en la Universidad Internacional Mundae

DECLARA:

Que, actuando con pleno conocimiento del marco normativo académico vigente y de las disposiciones aplicables en materia de integridad académica y propiedad intelectual, el Trabajo Final de Graduación titulado “Polimedicación psicotrópica y contención química en personas mayores institucionalizadas: la desprescripción como estrategia enfermera para proteger la calidad de vida” es de su exclusiva autoría y constituye una obra original, elaborada de manera autónoma, sin incurrir en plagio total o parcial, ni en prácticas contrarias a la ética académica.

Que todas las fuentes, ideas, datos y materiales procedentes de terceros han sido debidamente citados y referenciados conforme a las normas académicas exigidas.

Que asume plenamente la responsabilidad derivada de la autoría del trabajo presentado, tanto en lo relativo a su contenido como al uso de fuentes y materiales, respondiendo ante cualquier reclamación, controversia o incidencia que pudiera surgir en relación con derechos de propiedad intelectual o cualquier otro aspecto vinculado al mismo.

Asimismo, exonera expresamente a la Universidad Internacional Mundae, a su profesorado y a cualquier órgano académico de toda responsabilidad frente a posibles vulneraciones de derechos, inexactitudes, omisiones o cualquier otra irregularidad contenida en el trabajo presentado.

Y para que así conste, firma la presente declaración en Melilla, a 24 de noviembre de 2026.

Fdo.: _____ El Asisa Kaddur El Founti

# Dedicatoria

A las personas mayores que conocí en las prácticas, que me enseñaron sin saberlo que cuidar empieza por mirar. Y a quienes las cuidan cada noche sin que nadie lo cuente.

# Agradecimientos

A Nuria Gracia Carrillo, por orientar este trabajo con paciencia y exigencia, y por insistir en que una revisión se hace leyendo las fuentes y no los resúmenes. A las enfermeras y auxiliares de la residencia donde hice las prácticas, que me dejaron ver lo que no sale en los libros. A mi familia, que ha aguantado estos años de estudio con más paciencia de la que yo habría tenido. Y a las personas que viven en residencias, de quienes he aprendido más de lo que cabe en estas páginas.

# Índice de contenidos

Resumen..... 11

Abstract..... 12

1 Introducción..... 13

1.1 Envejecer en una residencia: cifras y contexto..... 13

1.2 Sujetar sin cuerdas: de la contención física a la contención química..... 15

1.3 Lo que cuesta un comprimido: riesgos de los psicofármacos en la persona mayor..... 18

1.4 Marco jurídico y recomendaciones de los comités..... 19

1.5 Desprescribir: concepto, proceso y herramientas..... 23

1.6 Y la enfermera, ¿dónde está?..... 25

2 Justificación..... 26

3 Objetivos..... 27

4 Metodología..... 28

4.1 Diseño..... 28

4.2 Pregunta de revisión..... 28

4.3 Fuentes de información y estrategia de búsqueda..... 28

4.4 Criterios de selección..... 30

4.5 Proceso de selección y extracción de la información..... 31

4.6 Consideraciones éticas..... 32

5 Resultados..... 33

5.1 Descripción del corpus..... 33

5.2 Sujeción física y consumo de psicofármacos en las residencias españolas: lo que se mide y lo que no....35
5.3 El daño de los psicofármacos, sea cual sea su finalidad....37
5.4 Desprescribir psicofármacos: eficacia y seguridad, estudio a estudio....39
5.5 Las alternativas: qué funciona cuando no se da el comprimido....45
5.6 Lo que hacen las enfermeras en los programas que funcionan....46
5.7 Del requisito normativo al registro enfermero....47
6 Discusión....49
6.1 Consensos, controversias y vacíos de la evidencia....49
6.2 Por qué la desprescripción es un cuidado....51
6.3 Una ruta enfermera para una residencia real....52
6.4 Limitaciones....55
6.5 Líneas futuras....56
7 Conclusiones....57
Referencias bibliográficas....59
Anexos....67
Anexo A. Sintaxis completa de las cadenas de búsqueda en PubMed....67
Anexo B. Criterios STOPP versión 3 relacionados con los psicofármacos en personas mayores....67
Anexo C. Lista de comprobación enfermera para revisar y registrar un psicofármaco pautado a demanda o sin indicación específica....69

# Índice de figuras

Figura 1. *El continuo de la contención: de la menos visible a la más regulada*.....16

Figura 2. *Cronología de las alertas, normas y herramientas que enmarcan la contención química en España*.....22

Figura 3. *Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de los documentos*...31

Figura 4. *Prevalencia de sujeciones físicas en residencias: España frente a referencias internacionales*.....35

Figura 5. *Aumento absoluto de la mortalidad a 180 días y número necesario para dañar con cada antipsicótico en personas con demencia*.....39

Figura 6. *Riesgo de caída asociado a los principales grupos de psicofármacos en personas mayores*.....39

Figura 7. *Tres programas, tres medidas: residentes con antipsicótico pautado (HALT), psicofármacos por residente (Barcelona) y dosis diaria (45 residencias españolas)*.....43

Figura 8. *Ruta enfermera de revisión y desprescripción de psicofármacos en residencias*. .....53

# Índice de tablas

Tabla 1. *Formas de contención descritas en los documentos de referencia españoles*...16

Tabla 2. *Marco ético y normativo aplicable a las contenciones en residencias de personas mayores*..... 21

Tabla 3. *Herramientas explícitas de apoyo a la desprescripción con interés para los psicofármacos en residencias*..... 24

Tabla 4. *Estrategia de búsqueda en PubMed (1 de noviembre de 2026) y registros recuperados*..... 29

Tabla 5. *Criterios de inclusión y exclusión de los documentos*.....30

Tabla 6. *Características y hallazgos principales de los estudios y revisiones sobre sujeciones, consumo de psicofármacos, daño, alternativas y papel enfermero*.....33

Tabla 7. *Qué mide cada tipo de dato disponible y qué permite afirmar sobre la contención farmacológica*..... 37

Tabla 8. *Daños cuantificados asociados al uso de psicofármacos y de sujeciones en personas mayores*.....37

Tabla 9. *Programas de reducción de psicofármacos y ensayos de retirada: diseño, personas incluidas, variable medida, seguimiento y límites*.....41

Tabla 10. *Intervenciones no farmacológicas para los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia con mejor respaldo*.....45

Tabla 11. *Funciones de la enfermería identificadas en los programas y revisiones incluidos*.....46

Tabla 12. *Requisitos normativos para toda contención y su traducción a la revisión y al registro enfermero de los psicofármacos*.....48

Tabla 13. *Síntesis de la revisión: consensos, controversias y vacíos de conocimiento*....49

Tabla 14. *Pauta orientativa de retirada gradual de psicofármacos y vigilancia enfermera, según los algoritmos de las guías canadienses*.....54

Tabla 15. *Indicadores propuestos para el seguimiento del uso de psicofármacos y de su revisión en el plan de atención libre de sujeciones de una residencia*.....54

Tabla 16. *Cadenas de búsqueda completas y resultados*.....67

Tabla 17. *Criterios STOPP v3 de interés para la revisión de psicofármacos en residencias*. .....68

Tabla 18. *Lista de comprobación enfermera para la revisión y el registro de un psicofármaco a demanda o sin indicación específica*.....69

# Índice de abreviaturas

| | |
|---|---|
| AEMPS | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
| ATC | Clasificación anatómica, terapéutica y química de los medicamentos |
| BOE | Boletín Oficial del Estado |
| CBE | Comité de Bioética de España |
| CHROME | CHemical Restraints avOidance MEthodology (evitación de la contención química) |
| CMAI | Cohen-Mansfield Agitation Inventory |
| CSIC | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
| DART-AD | Dementia Antipsychotic Withdrawal Trial |
| DEMQOL | Dementia Quality of Life (escala de calidad de vida en la demencia) |
| DICE | Describir, Investigar, Crear, Evaluar |
| ECA | Ensayo clínico aleatorizado |
| EMPOWER | Eliminating Medications Through Patient Ownership of End Results |
| EPCentCare | Effect of Person-Centred Care on antipsychotic drug use |
| FGE | Fiscalía General del Estado |
| HALT | Halting Antipsychotic use in Long-Term care |
| HR | Hazard ratio (razón de riesgos instantáneos) |
| IC 95 % | Intervalo de confianza del 95 % |
| INE | Instituto Nacional de Estadística |
| ISRS | Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina |
| LESS-CHRON | List of Evidence-baSed depreScribing for CHRONic patients |
| NICE | National Institute for Health and Care Excellence |
| NNH | Número necesario para dañar |
| NNT | Número necesario para tratar |
| NPI-NH | Neuropsychiatric Inventory, versión para residencias |
| OR | Odds ratio (razón de probabilidades) |
| PEO | Población, Exposición, Resultados (estructura de la pregunta de revisión) |
| RR | Riesgo relativo |
| SAAD | Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia |
| SEGG | Sociedad Española de Geriatría y Gerontología |
| SNC | Sistema nervioso central |
| SPCD | Síntomas psicológicos y conductuales de la demencia |
| STOPP/START | Screening Tool of Older Persons' Prescriptions / Screening Tool to Alert to Right Treatment |
| STOPPFrail | Screening Tool of Older Persons Prescriptions in Frail adults |
| WHELD | Improving Well-being and Health for People with Dementia |

# Resumen

A una persona mayor que vive en una residencia se la puede sujetar de dos maneras. Una es física, con cinturones y barandillas; la otra es farmacológica, y casi nunca se la llama por su nombre. De esta segunda trata el presente trabajo, cuyo objetivo fue analizar la evidencia sobre la contención química en personas mayores institucionalizadas y sobre la desprescripción de psicofármacos como estrategia enfermera para proteger su calidad de vida. Se hizo una revisión narrativa a partir de una búsqueda en PubMed realizada el 1 de noviembre de 2026 (seis cadenas, 902 registros, 759 sin duplicados), completada con fuentes institucionales, normativa y bola de nieve. Se incluyeron 56 documentos, 36 de ellos artículos de 2014 a 2026. Tomar un psicofármaco no es lo mismo que estar contenido, porque la contención depende de la finalidad con que se da el fármaco, y ningún estudio español la ha cuantificado. Las cifras solo describen el contexto: en un estudio multicéntrico el 84,9 % de los residentes llevaba alguna sujeción física, la prescripción de antipsicóticos en la demencia se duplicó entre 2002 y 2018 y vivir en una residencia multiplica por doce la probabilidad de recibir uno. El daño de estos fármacos está medido en mortalidad (número necesario para dañar de 26 a 50) y en caídas (odds ratio de 1,4 a 2,0). Los programas de reducción no miden lo mismo. En HALT hubo un 81,7 % menos de residentes con antipsicótico pautado a los doce meses; en Barcelona la media de psicofármacos por residente pasó de 2,71 a 2,01 a los seis meses; en 45 residencias españolas la dosis de antipsicótico bajó entre un 23 % y un 28 % frente a controles. Donde se midieron, síntomas, caídas e ingresos no aumentaron, aunque las muestras eran seleccionadas, casi nunca había grupo control y quien tiene síntomas graves puede recaer. Se concluye que revisar y desprescribir psicofármacos es un cuidado enfermero: la enfermera detecta las pautas dudosas, valora las causas de la conducta, propone cambios con los criterios STOPP/START, vigila la retirada y registra lo que exigen la Instrucción 1/2022 de la Fiscalía y el Acuerdo de acreditación de 2022. Se propone una ruta enfermera en seis pasos, con indicadores.

**Palabras clave:** Desprescripción; contención química; residencias de personas mayores; psicofármacos; enfermería geriátrica.

# Abstract

An older person living in a nursing home can be restrained in two ways. One is physical, with belts and bed rails; the other is pharmacological, and it is seldom called by that name. This work deals with the second. Its aim was to analyse the available evidence on chemical restraint in institutionalised older people and on deprescribing psychotropic drugs as a nursing strategy to protect their quality of life. A narrative review was carried out, based on a PubMed search run on 1 November 2026 (six strings, 902 records, 759 after duplicate removal) and completed with institutional sources, legislation and snowballing. A total of 56 documents were included, 36 of them articles published between 2014 and 2026. Taking a psychotropic drug is not the same as being restrained, since restraint depends on the purpose for which the drug is given, and no Spanish study has quantified it. The figures only describe the context: in a multicentre study, 84.9% of residents had at least one physical restraint, antipsychotic prescribing in dementia doubled between 2002 and 2018, and living in a nursing home makes receiving an antipsychotic twelve times more likely. The harm of these drugs has been measured in mortality (number needed to harm from 26 to 50) and in falls (odds ratios from 1.4 to 2.0). Reduction programmes do not measure the same thing. In HALT, 81.7% fewer residents were on a regular antipsychotic at twelve months; in Barcelona, the mean number of psychotropics per resident went from 2.71 to 2.01 at six months; in 45 Spanish nursing homes, the antipsychotic dose fell by 23% to 28% compared with controls. Where they were measured, symptoms, falls and admissions did not increase, although samples were selected, control groups were rare and residents with severe symptoms may relapse. The review concludes that reviewing and deprescribing psychotropics is nursing care: the nurse detects questionable orders, assesses the causes of the behaviour, proposes changes using the STOPP/START criteria, monitors the taper and documents what the Public Prosecutor's Instruction 1/2022 and the 2022 accreditation Agreement require. A six-step nursing pathway with indicators is proposed.


**Keywords:** Deprescribing; chemical restraint; nursing homes; psychotropic drugs; geriatric nursing.

# 1 Introducción

En la residencia donde hice las prácticas hay una escena que se repite. Diez de la noche. La planta ya está más tranquila y una auxiliar va repartiendo los últimos vasitos de medicación. En uno de ellos va una quetiapina de 25 mg que nadie recuerda quién empezó ni por qué: en la hoja de tratamiento pone “si agitación”, pero lleva dos años dándose todas las noches. Yo no sabía si aquello era un tratamiento o una sujeción, y creo que en la planta no lo sabía nadie. Para saberlo habría que mirar con qué indicación se pautó, con qué finalidad se sigue dando y cómo queda registrada cada toma. De esa escena sale este trabajo, y también de la pregunta que me hice entonces: qué pasaría si alguien con criterio, y con tiempo, se sentara a revisar esos vasitos uno por uno.

No es una pregunta tan ingenua, o no del todo. La Fiscalía General del Estado vigila desde 2022 el uso de medios de contención mecánicos y farmacológicos en los centros residenciales; el sistema de acreditación de la dependencia reconoce el derecho a una atención libre de sujeciones “ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas”; y el Defensor del Pueblo, en junio de 2026, ha extendido al ámbito sociosanitario su guía de buenas prácticas en contenciones (15,19,45). El marco, pues, ya existe. Falta, a mi juicio, que quienes pasamos el turno junto al carro de medicación sepamos distinguir el psicofármaco que trata del que solo contiene, y sepamos también lo que cuesta mantenerlo y cómo se retira. Esta revisión quiere contribuir a eso.

## 1.1 Envejecer en una residencia: cifras y contexto

España envejece, y va a seguir haciéndolo. La nota de prensa de las Proyecciones de Población que el Instituto Nacional de Estadística publicó en junio de 2026 sitúa a las personas de 65 o más años en el 21,1 % de una población residente de unos 49,6 millones, y prevé que llegue al 30,9 % en 2076 (24). Parte de esas personas vive en residencias. Según el último perfil estadístico de Envejecimiento en Red hay 5.573 centros residenciales y 393.581 plazas, 4,2 por cada 100 mayores de 65 años, con una ocupación cercana al 86 % y una oferta privada que más que duplica a la pública (42). Viene a ser la población de Bilbao viviendo en instituciones.

Quien vive hoy en una residencia tiene poco que ver con quien vivía allí hace treinta años. Los centros de los estudios revisados se parecen bastante: edad media por encima de los 80 años, tres mujeres por cada hombre, dependencia funcional importante y mucha demencia. En el centro sociosanitario canario del estudio CHROME, el 77,4 % de los 288 residentes tenía un diagnóstico de demencia (39). En las siete residencias del área metropolitana de Barcelona que estudiaron Massot Mesquida y colaboradores, la edad media era de 87 años y el 75 % eran mujeres (35). Y los once estudios de la revisión Cochrane sobre sujeciones físicas, con 19.003 participantes, se hicieron en residencias donde todos los residentes tenían demencia, con una edad media de 85 años (38). Es una población muy frágil, y con poca voz.

A la fragilidad se le suma la polimedicación. En la residencia de Lleida que estudiaron Ubeda y su equipo, cada residente tomaba una media de cinco fármacos; el 48 % cumplía al menos un criterio STOPP de prescripción potencialmente inapropiada y el 25 % al menos un criterio Beers. Las benzodiacepinas de vida media larga encabezaban las dos listas, y el número de fármacos se correlacionaba significativamente con el de prescripciones inapropiadas (53). Para Scott y colaboradores, de hecho, el predictor aislado más importante de prescripción inapropiada y de acontecimientos adversos en pacientes mayores es el número de fármacos prescritos (50).

Los psicofármacos merecen capítulo aparte dentro de esa polimedicación. Un estudio publicado en 2025 con la base de datos BIFAP de atención primaria muestra que en España la prescripción de antipsicóticos a personas con demencia incidente se duplicó entre 2002 y 2018, del 12,6 % al 23,8 %. Hubo un descenso leve tras las alertas de 2004 y, desde 2007, una subida sostenida impulsada por la quetiapina, que pasó del 0,2 % al 16,4 %; la prevalencia española doblaba la del Reino Unido (48). En Gipuzkoa, sobre los 221.777 mayores de 60 años, vivir en una residencia multiplicó por 12,61 la probabilidad de recibir un antipsicótico, y el diagnóstico de demencia por 10,18, con un uso mayor entre las personas de nivel socioeconómico bajo (33). En el centro canario del estudio CHROME, antes de intervenir, el 42,7 % de los residentes con demencia analizados tomaba un neuroléptico atípico, el 25,2 % una benzodiacepina de vida media larga y el

47,7 % un hipnótico (39). Son cifras de consumo: dicen cuánto se prescribe y a quién, pero no con qué finalidad, y de esa diferencia trata el apartado siguiente.

## 1.2 Sujetar sin cuerdas: de la contención física a la contención química

Conviene empezar por las definiciones, porque en este tema los derechos de la persona dependen de cómo se llame cada cosa. La Instrucción 1/2022 toma de la Organización Mundial de la Salud la definición de contención mecánica o física, "la restricción de movimientos mediante cualquier método manual, dispositivo físico o mecánico, material o equipo conectado o adyacente al cuerpo del paciente, que él o ella no puede sacar fácilmente", y del Comité de Bioética de España la que entiende por contenciones físicas y farmacológicas las medidas "destinadas a privar a una persona de su libertad de movimiento" (11,19). Para la Fiscalía, en resumen, la contención es una medida de control del comportamiento que ejercen terceros a través del cuerpo o de la sedación.

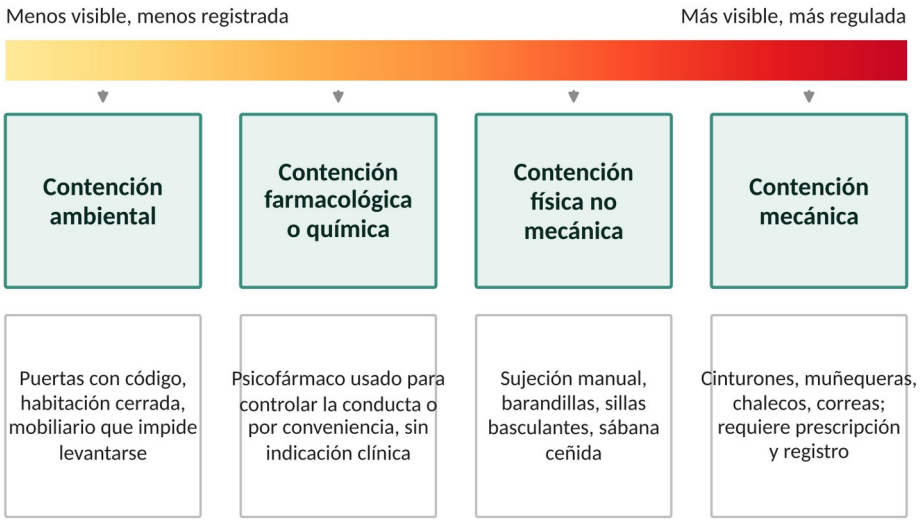
El matiz que aquí importa es el de la contención farmacológica o química. El documento de consenso del Comité Interdisciplinar de Sujeciones de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de 2014, la define como el uso de un fármaco expresamente con la finalidad de contener o restringir la libertad de movimientos. La equipara a la sujeción mecánica, le exige los mismos requisitos de consentimiento informado y deja fuera los psicofármacos usados con fines terapéuticos y no restrictivos (11,12). La Fiscalía es más concreta: señala que "en el grupo de contenciones farmacológicas o químicas se ubica el uso de benzodiazepinas o antipsicóticos, es decir, psicofármacos con capacidad sedativa", separa los tratamientos dirigidos a síntomas específicos de los que buscan "un efecto puramente sedativo" y sitúa el conflicto de derechos en "el uso crónico de la sedación farmacológica" (19). La Tabla 1 ordena las formas de contención que describen estos documentos y la Figura 1 las coloca en un continuo.

**Tabla 1.** *Formas de contención descritas en los documentos de referencia españoles.*

| Tipo | En qué consiste | Ejemplos habituales en una residencia | Dónde se regula o describe |
|---|---|---|---|
| Contención ambiental | Restricción de la libertad de movimiento mediante el espacio o el mobiliario, sin contacto con el cuerpo. | Puertas con código, habitación cerrada, mobiliario colocado para impedir el movimiento, silla de la que no es posible levantarse. | Instrucción 1/2022 (enumera la disposición del mobiliario entre las contenciones físicas) |
| Contención física manual o pasiva | Sujeción ejercida por una persona o por un dispositivo no mecánico. | Sujeción manual durante una cura, sábana ceñida, silla basculante, barandillas completas de cama. | Documento de consenso SEGG (2014); Comité de Bioética (2016) |
| Contención mecánica | Dispositivo adyacente al cuerpo que la persona no puede retirar por sí misma. | Cinturón abdominal o pélvico, muñequeras, tobilleras, chaleco, mesilla fija en la silla, pijama-saco. | Instrucción 1/2022; Acuerdo SAAD 2022; Defensor del Pueblo (2026) |
| Contención farmacológica o química | Fármaco administrado con la finalidad de controlar la conducta o la movilidad, sin indicación clínica específica o más allá del tiempo necesario. | Sedante para que la persona no deambule o para aligerar el turno. Una pauta “si agitación” dada cada noche o un hipnótico mantenido durante años no lo son por definición: obligan a revisar indicación, finalidad y registro. | SEGG (2014); Comité de Bioética (2016); Instrucción 1/2022; Acuerdo SAAD 2022 |
| Coerción psicológica | Amenaza, castigo o presión verbal para que la persona no se mueva o no pida. | “Si te levantas te atamos”, retirada de visitas o actividades como castigo. | Acuerdo SAAD 2022 (atención “libre de coerciones”) |

Fuente: elaboración propia a partir del Documento de consenso de la SEGG (12), del informe del Comité de Bioética de España (11), de la Instrucción 1/2022 (19) y del Acuerdo de acreditación del SAAD (45).

**Figura 1.** *El continuo de la contención: de la menos visible a la más regulada.*




Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 11, 12 y 19.

Un tratamiento y una sujeción no se distinguen por el nombre del fármaco, sino por para qué se da y por si alguien lo revisa. La misma risperidona puede ser tratamiento un lunes, con un síntoma diana identificado, la dosis mínima y una fecha para reevaluar, y sujeción

un jueves si se mantiene porque así la planta está más tranquila. De ahí que la Fiscalía insista en que “deben descartarse las órdenes facultativas genéricas de tratamiento”, en que toda contención “debe valorarse de forma individualizada”, y en que queda “totalmente proscrita” su utilización “con fines de disciplina o por conveniencia (ahorro de trabajo, esfuerzo o de recursos)” (19). En la misma línea, el Acuerdo de acreditación de 2022 coloca las sujeciones químicas en el mismo plano que las mecánicas (45).

De esa definición sale una distinción que mantengo en todo el trabajo. El consumo de psicofármacos es una cosa, y se lee en la hoja de tratamiento: cuántos residentes los toman, cuántos lleva cada uno, a qué dosis. La prescripción potencialmente inapropiada es otra, la que incumple un criterio explícito de duración, de indicación o de revisión. La contención farmacológica es más estrecha que las dos, porque exige una finalidad restrictiva, y la finalidad no consta en la hoja. Por eso una pauta “si agitación” que termina administrándose de forma rutinaria no puede llamarse sujeción sin más. Pide, eso sí, que se revisen su indicación, su finalidad y su registro, y solo después de esa revisión se puede decir qué era.

La sujeción visible ya es, en España, un problema reconocido. Estévez-Guerra y colaboradores, en un estudio transversal multicéntrico con 920 residentes de nueve centros canarios observados directamente en cuatro momentos, encontraron que el 84,9 % (IC 95 %: 81,7 a 88,1) llevaba al menos una sujeción física, con una variabilidad entre centros del 70,3 al 96,6 %. Sin contar las barandillas completas, la prevalencia bajaba al 36,6 %, y el motivo registrado en el 94,2 % de los casos era prevenir caídas. Los autores sitúan la prevalencia internacional en residencias entre el 6 y el 68 % y concluyen que la española está por encima (17). El Comité de Bioética ya lo había advertido: “el uso de contenciones en España es más frecuente que en los países de nuestro entorno” (11). Las consecuencias para el residente también están descritas: menor rendimiento cognitivo y en las actividades de la vida diaria, más dependencia para caminar, caídas, úlceras por presión e incontinencia (23) y, según la revisión de Evans y colaboradores, un posible aumento de la mortalidad, de las lesiones graves y de la duración de los ingresos (18).

Hay un temor bastante extendido, que he oído más de una vez en las plantas: que al quitar las correas aparezcan los comprimidos. Los datos, sin embargo, no lo confirman. El ensayo alemán de Köpke y colaboradores redujo las sujeciones del 31,5 % al 22,6 % en seis meses y no encontró diferencias en la prescripción de psicofármacos (27). La revisión Cochrane de 2023 llega a algo parecido: las intervenciones organizativas orientadas a una política de mínima sujeción probablemente tienen poco o ningún efecto sobre la prescripción de psicofármacos, las caídas o las lesiones (38). Es una buena noticia con un límite que reaparecerá en los resultados: esos ensayos miden prescripción, no finalidad, así que no dicen cuánta contención farmacológica había antes ni después de retirar las correas.

## 1.3 Lo que cuesta un comprimido: riesgos de los psicofármacos en la persona mayor

No es nueva la alarma sobre los antipsicóticos en la demencia. En marzo de 2004 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios comunicó que en los ensayos con olanzapina en ancianos con demencia la mortalidad había sido del 3,5 % frente al 1,5 % con placebo, y el ictus casi tres veces más frecuente; añadía que la olanzapina “no debe utilizarse en este grupo de pacientes” y que la risperidona quedaba en evaluación (3). Una segunda nota, en noviembre de 2008, extendió el aviso a los antipsicóticos clásicos después de que los estudios canadienses mostraran una mortalidad entre un 26 % y un 55 % mayor que con los atípicos, y anunció la actualización de todas las fichas técnicas (2). Entre una nota y otra, Schneider y colaboradores ya le habían puesto cifras al riesgo en un metaanálisis de 15 ensayos controlados con placebo: 3,5 % de muertes con antipsicótico atípico frente a 2,3 % con placebo, con una odds ratio de 1,54 (49).

Luego vinieron números todavía más incómodos. Con más de 90.000 veteranos con demencia, Maust y su equipo calcularon el número necesario para dañar a 180 días: 26 con haloperidol, 27 con risperidona, 40 con olanzapina y 50 con quetiapina, con una relación dosis-respuesta en los atípicos (36). En el ensayo DART-AD, 165 personas con Alzheimer institucionalizadas se asignaron al azar a seguir con el antipsicótico o a cambiarlo por placebo. En el seguimiento a largo plazo, la supervivencia fue del 70 %

frente al 77 % a los doce meses, del 46 % frente al 71 % a los veinticuatro y del 30 % frente al 59 % a los treinta y seis (6).

El otro gran coste son las caídas, y aquí entran más fármacos que los antipsicóticos. En el metaanálisis de Seppala y colaboradores, con 248 estudios, las odds ratios ajustadas de caída fueron de 1,54 para los antipsicóticos, 1,57 para los antidepresivos (2,02 para los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), 1,42 para las benzodiacepinas en conjunto y 1,81 para las de acción larga (51). Los criterios Beers de 2023 lo convierten en recomendación fuerte: evitar antipsicóticos, benzodiacepinas y fármacos Z en personas con caídas o fracturas previas, evitar el uso simultáneo de tres o más fármacos activos sobre el sistema nervioso central y recordar que “las benzodiacepinas de acción corta no son más seguras que las de acción larga” (4). A ello se añade la carga anticolinérgica de antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos y varios antipsicóticos, que en mayores contribuye al deterioro cognitivo, a la pérdida funcional y a las caídas (22).

La línea temática de este trabajo es el impacto de la polimedicación en la calidad de vida, así que me parece justo preguntarse qué significa calidad de vida para alguien que vive en una residencia. Para las personas que he cuidado en las prácticas eran cosas muy concretas. Estar despiertas a la hora de comer. Reconocer a la nieta que viene el domingo. Llegar andando hasta el jardín, protestar cuando algo no gusta. La sedación crónica se lleva todo eso. Cuando los centros trabajan en la dirección contraria, con formación del personal y actividades centradas en la persona, la calidad de vida medida con escalas validadas mejora. En el ensayo WHELD, con 847 residentes con demencia de 69 residencias británicas, la intervención mejoró la calidad de vida (DEMQOL-Proxy, diferencia media de 2,54 puntos), la agitación y los síntomas neuropsiquiátricos, y aumentó un 19,7 % las interacciones positivas (5).

## 1.4 Marco jurídico y recomendaciones de los comités

El marco jurídico lleva más de veinte años construyéndose, y a varios niveles. En el plano internacional, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en vigor en España desde mayo de 2008, reconoce en su artículo 12 que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones, y exige que las

medidas relativas a su ejercicio respeten “los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona”. Su artículo 14 obliga a los Estados a asegurar que “la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad” (25). El Consejo de Europa, en la Recomendación CM/Rec(2014)2, lo traslada al terreno residencial: “las personas mayores que reciben atención institucional tienen derecho a la libertad de movimiento. Cualquier restricción deberá ser legal, necesaria y proporcionada” (13).

En el plano estatal, la Ley 41/2002 establece que toda actuación sanitaria necesita el consentimiento libre y voluntario de la persona, que ese consentimiento debe darse por escrito en los procedimientos con riesgos de notoria repercusión y que, si el paciente no puede decidir, el consentimiento por representación tiene que ser “adecuado a las circunstancias y proporcionado a las necesidades”, con participación del paciente “en la medida de lo posible” (29). El fondo del asunto lo cambió la Ley 8/2021, que sustituyó la incapacitación y la tutela por un sistema de apoyos y obligó a quien presta apoyo a actuar “atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias” de la persona, dejando las funciones representativas para casos excepcionales (30). Desde entonces, en teoría al menos, quien decide por un residente con demencia tiene que intentar decidir como lo habría hecho él.

Sobre esa base se apoyan los documentos que pasan del principio al procedimiento. El informe del Comité de Bioética de España de 2016 formula dieciséis recomendaciones. Prescribir contenciones, físicas o farmacológicas, “es competencia exclusiva del facultativo”, aunque en una urgencia enfermería “podría iniciar el procedimiento comunicándolo al médico con la menor demora posible”. El consentimiento tiene que ser explícito y contemporáneo, “no considerándose válidos los consentimientos genéricos ni los diferidos en el tiempo”, y la indicación, el uso y el tipo han de quedar “registrados siempre en la historia clínica” (11). La Instrucción 1/2022 de la Fiscalía lleva esos presupuestos a todo el territorio: prescripción facultativa individualizada salvo peligro inminente, consentimiento informado conforme a los artículos 8 y 9 de la Ley 41/2002, principios de “cuidado, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición del exceso”, protocolo de centro con vigilancia permanente y remisión periódica a la Fiscalía del listado de contenciones aplicadas, con su prescripción, su

duración y sus controles. Y recuerda, citando al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que una contención mecánica “debería durar minutos y no horas” (19).

Con el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales de 2022, la atención libre de sujeciones pasa a ser un requisito de acreditación. Todas las personas atendidas en el sistema de dependencia “tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas, y también libre de coerciones”. Cada centro tiene que contar con un Plan de atención libre de sujeciones aprobado por la Inspección e implantado antes del 30 de junio de 2025, y cualquier sujeción exige prescripción médica, supervisión técnica y consentimiento explícito para cada situación, ha de comunicarse al Ministerio Fiscal y tiene que quedar registrada en el historial de la persona (45). La guía del Defensor del Pueblo de 2026 traslada todo esto al entorno sociosanitario. La contención es “una medida de carácter estrictamente excepcional”, “no pueden establecerse indicaciones genéricas, permanentes o preventivas”, no se admite “como medida inespecífica de prevención de caídas” y los centros deben promover “la reducción progresiva y, en la medida de lo posible, la eliminación” de las contenciones (15). Este marco queda resumido en la Tabla 2, y la Figura 2 lo ordena en el tiempo.

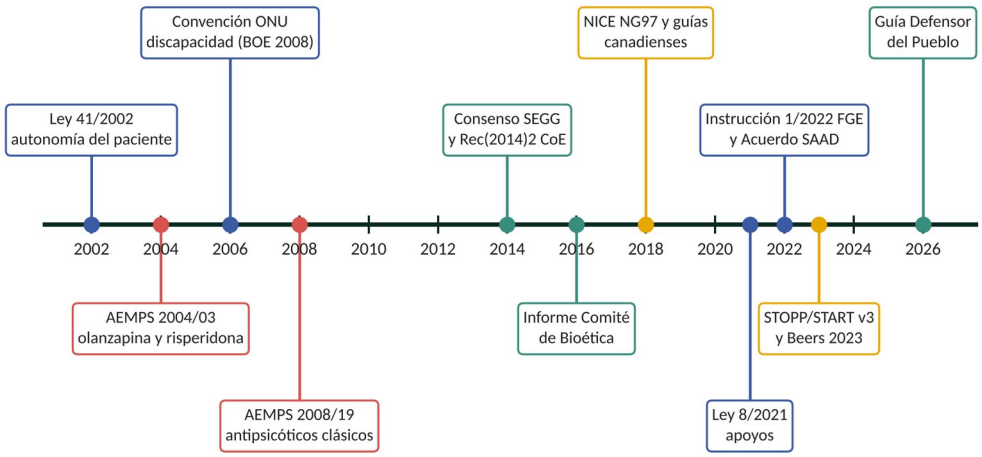
**Tabla 2.** *Marco ético y normativo aplicable a las contenciones en residencias de personas mayores.*

| Norma o documento | Año | Rango | Qué aporta al problema de la contención química |
|---|---|---|---|
| Ley 41/2002, de autonomía del paciente | 2002 | Ley básica estatal | Consentimiento libre y voluntario para toda actuación (art. 8); consentimiento por representación proporcionado y con participación de la persona (art. 9). |
| Notas informativas AEMPS 2004/03 y 2008/19 | 2004 y 2008 | Alertas de seguridad | Más mortalidad e ictus con antipsicóticos atípicos y clásicos en ancianos con demencia; olanzapina no debe usarse en esta indicación. |
| Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (BOE 2008) | 2006 (2008) | Tratado internacional | Capacidad jurídica en igualdad (art. 12); la discapacidad nunca justifica una privación de libertad (art. 14). |
| Recomendación CM/Rec(2014)2 del Consejo de Europa | 2014 | Recomendación | Libertad de movimiento en la atención institucional; toda restricción debe ser legal, necesaria y proporcionada (párr. 41). |
| Documento de consenso SEGG | 2014 | Consenso profesional | Define la sujeción química como uso de un fármaco con finalidad restrictiva y la equipara a la mecánica en requisitos de consentimiento. |

| Norma o documento | Año | Rango | Qué aporta al problema de la contención química |
|---|---|---|---|
| Informe del Comité de Bioética de España | 2016 | Informe consultivo | Dieciséis recomendaciones: último recurso, prescripción facultativa, consentimiento explícito y contemporáneo, registro en la historia clínica. |
| NICE NG97 y guías canadienses de desprescripción | 2018 | Guías de práctica clínica | Antipsicóticos solo ante riesgo de daño o malestar grave, dosis mínima, tiempo mínimo y revisión; desprescribir tras tres meses de estabilidad. |
| Ley 8/2021, de apoyo a las personas con discapacidad | 2021 | Ley estatal | Sustituye la incapacitación por apoyos; obliga a respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona. |
| Instrucción 1/2022 de la Fiscalía General del Estado | 2022 | Instrucción (BOE) | Presupuestos de toda contención mecánica o farmacológica; prohíbe órdenes genéricas y usos por conveniencia; listado periódico a la Fiscalía. |
| Acuerdo de acreditación y calidad del SAAD (Resolución 28/7/2022) | 2022 | Acuerdo del Consejo Territorial (BOE) | Derecho a una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas; Plan de atención libre de sujeciones antes del 30/6/2025. |
| Criterios STOPP/START v3 y Beers 2023 | 2023 | Herramientas de prescripción | Criterios explícitos para antipsicóticos, benzodiacepinas e hipnóticos en demencia, caídas y uso prolongado. |
| Guía del Defensor del Pueblo sobre contenciones | 2026 | Guía de buenas prácticas | Amplía al entorno sociosanitario: sin indicaciones genéricas ni preventivas, registro trazable, reducción progresiva y eliminación. |

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 25, 29, 30, 40, 41, 43 y 45.

**Figura 2.** *Cronología de las alertas, normas y herramientas que enmarcan la contención química en España.*




Fuente: elaboración propia.

Dentro de este marco hay un hueco que quiero señalar ya, aunque vuelva sobre él en los resultados. Casi todo lo que la norma manda contar y vigilar es contención mecánica, que empieza a una hora y termina a otra. La farmacológica apenas entra en esos listados,

porque para anotarla habría que haber revisado antes la finalidad de cada pauta, y esa revisión casi nunca se hace. Creo que el derecho a una atención libre de sujeciones químicas empieza por algo más modesto que una prohibición: revisar de forma periódica cada psicofármaco, con su indicación, su finalidad y su registro, y retirar el que no se sostenga.

## 1.5 Desprescribir: concepto, proceso y herramientas

Desprescribir no consiste solo en dejar de dar pastillas, aunque a veces se entienda así. Reeve y colaboradores, después de revisar 37 definiciones, propusieron entender la desprescripción como “el proceso de retirada de un medicamento inapropiado, supervisado por un profesional sanitario, con el objetivo de manejar la polifarmacia y mejorar los resultados” (44). Antes, y en español, Gavilán-Moral y su grupo la habían descrito como “el proceso de desmontaje de la prescripción de medicamentos por medio de su revisión y análisis, que concluye con la modificación de dosis, sustitución o eliminación de unos fármacos y adición de otros”. Plantearon también dos preguntas que siguen sirviendo al pie de la cama: si la esperanza de vida es menor que el tiempo que tarda el fármaco en dar beneficio, y si los objetivos de la prescripción son coherentes con los de los cuidados (21).

Scott y su equipo convirtieron el concepto en un protocolo de cinco pasos que puede servir de esqueleto a cualquier programa. Primero, averiguar todos los fármacos que toma la persona y el motivo de cada uno. Después, estimar su riesgo global de daño por fármacos, para decidir la intensidad de la intervención. Luego valorar cada fármaco según su beneficio y su daño, actuales o futuros, priorizar para la retirada los de peor balance y menor riesgo de rebote, y aplicar por último un régimen de retirada con vigilancia estrecha (50). Los pasos tres y cuatro necesitan criterios explícitos; la Tabla 3 compara los más utilizados.

**Tabla 3.** *Herramientas explícitas de apoyo a la desprescripción con interés para los psicofármacos en residencias.*

| Herramienta | Origen y año | Contenido | Qué dice de los psicofármacos | Utilidad para enfermería |
|---|---|---|---|---|
| STOPP/START versión 3 (versión española 2023) | Panel Delphi europeo, 2023 | 190 criterios: 133 STOPP (fármacos a evitar) y 57 START (omisiones) | Antipsicóticos en SPCD más de 12 semanas sin fracaso de lo no farmacológico (D15) o más de 3 meses sin revisión (D5); benzodiacepinas más de 4 semanas (D8), para la agitación de la demencia (D9) o en caídas recurrentes (K1); antipsicóticos en caídas (K2) o como hipnóticos (D16) | Lista de comprobación mensual de la hoja de tratamiento; argumento objetivo para la sesión clínica |
| Criterios Beers 2023 | American Geriatrics Society, 2023 | Fármacos a evitar en mayores de 65 años, interacciones fármaco-enfermedad y combinaciones | Evitar antipsicóticos salvo indicaciones aprobadas o daño sustancial tras fracaso documentado de lo no farmacológico; evitar benzodiacepinas y fármacos Z; no más de dos fármacos activos sobre el SNC | Criterio de alarma ante tres psicofármacos o un “si precisa” crónico |
| STOPPFrail versión 2 | Curtin, Gallagher y O'Mahony, 2021 | 25 criterios para mayores frágiles con esperanza de vida limitada, con método para identificarlos | Prioriza retirar lo que no aporta beneficio a corto plazo y subraya la decisión compartida | Encaja con el perfil de gran dependencia de la residencia y con los cuidados al final de la vida |
| LESS-CHRON | Rodríguez-Pérez y colaboradores (Sevilla), 2017 | 27 criterios para pacientes crónicos con multimorbilidad | Para cada criterio indica la situación que permite desprescribir, la variable que vigilar y el tiempo mínimo de seguimiento | Es la única que dice qué vigilar y durante cuánto tiempo: ideal para el plan de cuidados |
| Guías canadienses de desprescripción | Bjerre y colaboradores; Pottie y colaboradores, 2018 | Recomendaciones GRADE con algoritmo de decisión | Desprescribir antipsicóticos tras tres meses de SPCD estabilizados; ofrecer la retirada gradual de benzodiacepinas a toda persona mayor de 65 años, sea cual sea la duración | Pautas de reducción escalonada y lista de síntomas de retirada |
| Método DICE | Kales, Gitlin y Lyketsos, 2015 | Describir, Investigar, Crear, Evaluar | Lo no farmacológico es la primera línea; el antipsicótico, la excepción justificada | Estructura la valoración enfermera de la conducta antes de pedir un “si precisa” |

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 4, 9, 14, 16, 26, 41, 43 y 47.

La guía NICE NG97 resume el consenso clínico sin rodeos: ofrecer antipsicóticos a una persona con demencia solo si corre riesgo de dañarse o de dañar a otros, o si la agitación, las alucinaciones o los delirios le causan un malestar grave; usar la dosis eficaz más baja durante el menor tiempo posible; reevaluar como mínimo cada seis semanas, y probar antes las intervenciones psicosociales y ambientales (40). La Comisión Lancet de 2024 añade que no hay ensayos que avalen el uso de benzodiacepinas y fármacos Z para el

sueño en la demencia, y que a dosis altas se asocian a más fracturas e ictus, por lo que conviene evitarlos (31). Las herramientas, en resumen, existen, y en lo esencial dicen lo mismo. Queda menos claro quién las aplica en una residencia, y de eso trata el último apartado de esta introducción.

## 1.6 Y la enfermera, ¿dónde está?

Sobre el papel, la prescripción es médica, y así lo recuerdan el Comité de Bioética y la Fiscalía (11,19). En la práctica, muchas de las decisiones de las que depende que un fármaco trate o sujete se toman en el control de enfermería. Dar o no dar el "si precisa". Avisar al médico de guardia o esperar a la mañana siguiente. Describir la conducta como "agitación" o como "dolor no tratado", registrar lo que pasó o no registrarlo. La propia Instrucción 1/2022 encarga a enfermería la supervisión de la persona contenida, con higiene, constantes, cambios posturales, contacto verbal y aporte de alimentos y líquidos (19), y el Comité de Bioética, como ya se ha visto, le permite iniciar el procedimiento en una urgencia cuando no hay médico localizable (11). Aunque no firmemos la prescripción, estamos al principio de la cadena y también al final.

La literatura sobre ese papel es reciente y apunta en la misma dirección. En la revisión de alcance de Barbuiani y colaboradores, con 28 estudios, las intervenciones dirigidas por enfermería reducen la medicación potencialmente inapropiada, y la colaboración interdisciplinar, la formación y las herramientas de apoyo a la decisión funcionan como facilitadores (7). La revisión integradora de Vaismoradi y colaboradores, centrada en la larga estancia, identifica como obstáculos la falta de conocimientos, la falta de confianza y la poca presencia en las discusiones del equipo (54). Hay otro dato que da que pensar. En la revisión sistemática de Bibi y colaboradores sobre los factores que explican la variación en el uso de antipsicóticos entre residencias, una mejor formación del personal y una mayor disponibilidad de enfermeras tituladas se asociaron a un uso menor (8). La dotación de enfermeras se discute casi siempre como un asunto laboral, de ratios y de convenios. Vista desde aquí, tiene que ver también con cuántos de esos vasitos se reparten cada noche.

# 2 Justificación

Elegí este tema por indignación y por curiosidad. La indignación viene de las prácticas, de la escena del vasito con la que abro la introducción y de otras parecidas: personas dormidas a la hora de comer por un fármaco que nadie había revisado en años, sin que ningún registro dijera para qué se daba. La curiosidad llegó al empezar a leer: la evidencia para hacerlo de otra manera lleva más de una década publicada y es bastante sólida. De esa distancia entre lo que se sabe y lo que se hace nace este trabajo.

Dentro de la línea del impacto de la polimedicación en la calidad de vida del anciano, la contención química es seguramente la expresión más cruda del problema. Sedar de manera crónica a una persona que no puede protestar le quita calidad de vida de la forma más directa, y aun así es de lo menos estudiado desde la enfermería española. Los trabajos españoles sobre sujeciones se han centrado en las físicas (17); los programas de desprescripción en residencias los coordinan médicos, farmacéuticos o psicólogos, aunque en todos aparece la enfermera (20,35,39,56). No he encontrado ninguno que junte las dos cosas y las mire desde nuestra profesión.

El calendario empuja también. El plazo del Acuerdo de acreditación para que cada centro implantara un plan de atención libre de sujeciones venció el 30 de junio de 2025 (45). Desde 2022 la Fiscalía pide listados periódicos de contenciones (19), y la guía del Defensor del Pueblo de 2026 llega por primera vez a las residencias (15). El derecho ya está reconocido; faltan herramientas para cumplirlo en el día a día, y quienes vamos a usarlas, o a dejarlas en un cajón, somos las enfermeras que nos incorporamos ahora.

Queda, por último, una razón profesional. La desprescripción de psicofármacos es un terreno donde la enfermería tiene competencias propias, de la valoración de la conducta a la vigilancia de la retirada, y la literatura reciente le pide un paso adelante (7,54). Hay también un motivo formativo: una revisión obliga a buscar, a leer con criterio y a separar lo demostrado de lo que solo se repite, como luego se nos exigirá en la práctica. El resultado, eso sí, tiene que poder usarlo una enfermera un martes por la mañana en una residencia de ochenta plazas.

# 3 Objetivos

El objetivo general de este trabajo es analizar la evidencia disponible sobre la contención química en personas mayores institucionalizadas y sobre la desprescripción de psicofármacos como estrategia para proteger su calidad de vida, con especial atención al papel que la enfermería desempeña, o puede desempeñar, en ese proceso.

Para llegar a él me planteé cuatro objetivos específicos. El primero, delimitar conceptualmente la contención química frente al tratamiento psicofarmacológico y describir el marco ético y normativo que la regula en España. El segundo, describir la magnitud del uso de sujeciones físicas y de psicofármacos en las residencias españolas, y los daños que ese uso provoca en las personas mayores. El tercero, sintetizar la evidencia sobre la eficacia y la seguridad de las intervenciones de desprescripción de psicofármacos y de las alternativas no farmacológicas en el ámbito residencial. Y el cuarto, identificar las funciones que la enfermería asume en esos programas y proponer, a partir de ellas, una ruta de actuación enfermera con indicadores de seguimiento que puedan aplicarse en una residencia.

# 4 Metodología

## 4.1 Diseño

Se ha realizado una revisión narrativa de la literatura, que es una de las modalidades previstas en la normativa de elaboración del Trabajo Final de Graduación, dentro del área temática “Salud mental y envejecimiento” y de la línea “Impacto de la polimedicación en la calidad de vida del anciano”. Elegí esta modalidad, y no una revisión sistemática, porque el objeto del trabajo es heterogéneo por fuerza. Hay que combinar evidencia clínica sobre eficacia y seguridad con datos epidemiológicos españoles, documentos normativos y literatura sobre el papel profesional, y una pregunta así se responde integrando fuentes distintas, no agregando resultados comparables. Aun así he procurado que la búsqueda sea reproducible y que pueda seguirse cómo se ha construido el corpus.

## 4.2 Pregunta de revisión

La pregunta se formuló con una estructura PEO adaptada. La población son las personas de 65 o más años que viven en residencias u otros centros de larga estancia. La exposición tiene dos caras: el uso de psicofármacos, sobre todo cuando cumple una función de contención, y las intervenciones para reducirlos. Preferí mantener las dos juntas antes que partir la revisión en dos. Como resultados se buscaron el uso de psicofármacos y de sujeciones, los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, las caídas, la mortalidad y la calidad de vida, y de manera transversal las funciones de la enfermería. Quitada la plantilla, la pregunta era qué es la contención química, cuánto daño hace, si puede deshacerse sin perjudicar a la persona y qué le toca hacer a la enfermera.

## 4.3 Fuentes de información y estrategia de búsqueda

La búsqueda principal se hizo el 1 de noviembre de 2026 en PubMed, que indexa MEDLINE y la Cochrane Database of Systematic Reviews. Se construyeron seis cadenas que combinan mediante operadores booleanos términos de desprescripción y retirada,

de psicofármacos (antipsicóticos, benzodiacepinas, hipnóticos), de contención química y física, de prescripción potencialmente inapropiada, de enfermería y de contexto español, acotados siempre al ámbito residencial y a la población mayor. El periodo se limitó a las publicaciones de 2014 a 2026 y los idiomas, salvo en la cadena de contexto español, al inglés y al español. Las seis cadenas devolvieron 902 registros, que se quedaron en 759 una vez eliminados los 143 duplicados entre cadenas. La Tabla 4 recoge cada cadena abreviada con su resultado; el Anexo A reproduce la sintaxis completa.

**Tabla 4.** *Estrategia de búsqueda en PubMed (1 de noviembre de 2026) y registros recuperados.*

| Cadena | Bloque conceptual | Términos principales (forma abreviada) | Filtros | Registros |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Desprescripción de psicofármacos en residencias | deprescrib*, withdrawal, discontinuation, dose reduction AND antipsychotic*, psychotropic*, benzodiazepine*, hypnotic* AND nursing home*, long-term care, care home*, residential care, institutionali* AND aged, elderly, older | 2014-2026; inglés o español | 117 |
| S2 | Contención química | chemical restraint*, pharmacological restraint* AND aged, elderly, older, dementia | 2014-2026; inglés o español | 74 |
| S3 | Sujeciones físicas en residencias | physical restraint*, mechanical restraint* AND nursing home*, long-term care, care home*, residential care AND prevalence, reduc*, intervention*, review, randomized controlled trial | 2014-2026; inglés o español | 109 |
| S4 | Prescripción inapropiada y herramientas | potentially inappropriate, STOPP, Beers criteria, STOPPFrail AND nursing home*, long-term care, institutionali*, care home* AND psychotropic*, antipsychotic*, benzodiazepine*, polypharmacy | 2014-2026; inglés o español | 252 |
| S5 | Papel de la enfermería | nurs* AND deprescrib*, medication review, antipsychotic reduction, psychotropic reduction AND nursing home*, long-term care, care home* AND dementia, aged | 2014-2026; inglés o español | 278 |
| S6 | Contexto español | Spain, Spanish, España AND nursing home*, long-term care, residen*, institutionali* AND psychotropic*, antipsychotic*, benzodiazepine*, physical restraint*, polypharmacy, inappropriate prescribing AND aged, elderly, older | 2014-2026 | 72 |
| **Total de registros recuperados (suma de cadenas)** | | | | **902** |
| **Registros únicos tras eliminar duplicados** | | | | **759** |

Fuente: elaboración propia. Los asteriscos indican truncamiento; la sintaxis completa figura en el Anexo A.

La búsqueda en bases de datos se completó por tres caminos. El primero fue consultar directamente las fuentes institucionales y normativas que PubMed no indexa: el Boletín Oficial del Estado para las leyes, la Instrucción de la Fiscalía y el Acuerdo de acreditación; las notas de seguridad de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; los informes del Comité de Bioética de España, de la Sociedad Española de Geriatría y

Gerontología y del Defensor del Pueblo; la guía NICE NG97; y las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y del portal Envejecimiento en Red del CSIC. El segundo fue una búsqueda en bola de nieve a partir de las listas de referencias de los artículos incluidos, que recuperó seis estudios anteriores a 2014 que la literatura posterior sigue tratando como fundacionales: el metaanálisis y el ensayo de retirada que fijaron el riesgo de los antipsicóticos, el ensayo alemán sobre sujeciones, la revisión sobre las lesiones que causan y los dos trabajos españoles pioneros sobre desprescripción y prescripción inapropiada en residencias. El tercero fue buscar en Google Scholar literatura gris española sobre programas libres de sujeciones; lo que llegó por esa vía, sobre todo el documento de consenso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, se cuenta entre los documentos institucionales.

## 4.4 Criterios de selección

Los criterios de inclusión y exclusión se fijaron antes de empezar a cribar, y la Tabla 5 los recoge. El que más dudas me dio fue el de la población comunitaria. Alguno de los mejores ensayos sobre retirada de benzodiacepinas se hizo en farmacias comunitarias y no en residencias, y decidí incluirlo como evidencia indirecta, señalada siempre como tal, antes que perder lo que enseña.

**Tabla 5.** *Criterios de inclusión y exclusión de los documentos.*

| Dimensión | Criterios de inclusión | Criterios de exclusión |
|---|---|---|
| Población | Personas de 65 o más años que viven en residencias, centros sociosanitarios u otros centros de larga estancia; estudios en población mayor general cuando aportan datos sobre riesgos de los psicofármacos | Población pediátrica o adulta joven; unidades de agudos de psiquiatría; estudios exclusivamente comunitarios, salvo los ensayos de retirada de psicofármacos en mayores de 65 años, incluidos como evidencia indirecta |
| Tema | Uso de psicofármacos o de sujeciones como contención; programas de desprescripción o reducción de psicofármacos; alternativas no farmacológicas a los SPCD; marco ético y normativo; papel de la enfermería | Psicofármacos en indicaciones psiquiátricas primarias (esquizofrenia, trastorno bipolar); contención en urgencias o en unidades de agudos |
| Diseño | Revisiones sistemáticas y metaanálisis, ensayos clínicos, estudios cuasiexperimentales, estudios observacionales, guías de práctica clínica, documentos de consenso, normativa y estadísticas oficiales | Cartas sin datos originales, protocolos de estudio, resúmenes de congreso, editoriales de opinión sin revisión de la literatura |

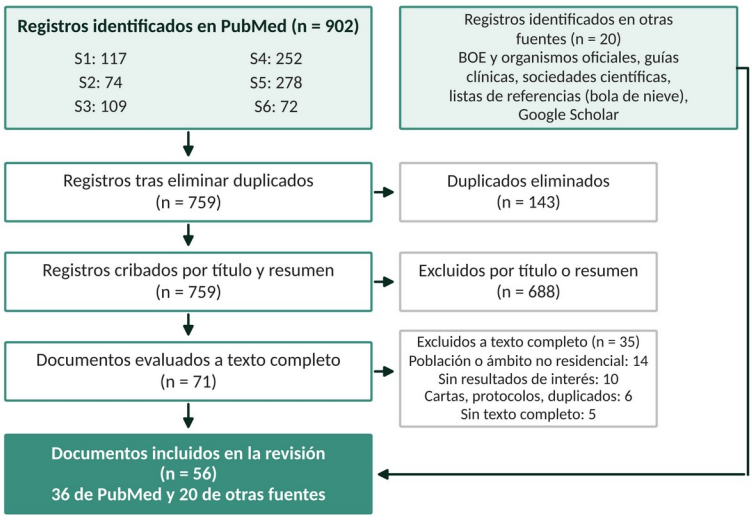
| Dimensión | Criterios de inclusión | Criterios de exclusión |
|---|---|---|
| Tiempo e idioma | Publicaciones de 2014 a 2026 en inglés o español; estudios anteriores a 2014 solo por bola de nieve, cuando la literatura posterior los considera de referencia | Publicaciones anteriores a 2014 localizadas únicamente en las bases de datos; otros idiomas |
| Acceso | Texto completo disponible o resumen estructurado con datos suficientes para la extracción | Sin acceso al texto completo ni al resumen con datos |

Fuente: elaboración propia.

## 4.5 Proceso de selección y extracción de la información

El cribado lo hice yo sola y en dos fases. En la primera leí los títulos y los resúmenes de los 759 registros únicos y descarté 688 porque no cumplían los criterios de población, tema o diseño. En la segunda evalué a texto completo 71 documentos y excluí 35: catorce por población o ámbito no residencial, diez por no aportar ninguno de los resultados de interés, seis por el tipo de publicación (cartas, protocolos o publicaciones duplicadas de un mismo estudio) y cinco por no disponer del texto completo. Quedaron 36 artículos procedentes de las bases de datos. A ellos se sumaron los 20 que llegaron por las otras vías, es decir, los seis estudios recuperados por bola de nieve y los catorce documentos institucionales, normativos o estadísticos, hasta un total de 56. El diagrama de flujo de la Figura 3 resume el proceso.

**Figura 3.** *Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de los documentos.*




Fuente: elaboración propia, adaptando el esquema PRISMA a una revisión narrativa.

De cada documento anoté en una hoja de cálculo el primer autor y el año, el país, el diseño, el tamaño y las características de la muestra, el ámbito, la intervención o la exposición estudiada, la variable con que se midió cada resultado, el tiempo de seguimiento, los resultados principales con sus cifras y, cuando constaba, el papel de la enfermería. Como los programas de reducción no miden lo mismo (unos cuentan residentes tratados, otros prescripciones y otros dosis), sus resultados se presentan uno a uno, cada cual en su unidad, sin agregarlos en una cifra común. Para ponderar las fuentes las clasifiqué según su diseño en cinco niveles, de mayor a menor capacidad de establecer causalidad: revisiones sistemáticas y metaanálisis, junto con las revisiones de alcance e integradoras que siguen un método explícito de búsqueda; ensayos clínicos aleatorizados; estudios cuasiexperimentales con medidas antes y después; estudios observacionales; y guías, consensos y documentos normativos, que no demuestran causalidad pero fijan obligaciones y recomendaciones. Esa clasificación aparece en las tablas de resultados y guía la discusión, de manera que las afirmaciones causales se apoyan en los dos primeros niveles y las descriptivas en el resto.

## 4.6 Consideraciones éticas

El trabajo no ha supuesto la participación de personas ni el acceso a historias clínicas, por lo que no necesitó el dictamen de un comité de ética de la investigación. La escena con la que se abre la introducción es una composición a partir de situaciones vividas en las prácticas, sin ningún dato que permita identificar a una persona ni a un centro. Se han respetado la autoría y las normas de citación Vancouver, cada cifra se ha contrastado con su fuente original y las figuras de datos parten de los valores publicados en los artículos que se citan en cada pie.

# 5 Resultados

## 5.1 Descripción del corpus

Los 56 documentos incluidos forman tres grupos: 36 artículos localizados en PubMed y publicados entre 2014 y 2026, seis estudios anteriores recuperados por bola de nieve y catorce documentos institucionales, normativos o estadísticos. Si se ordenan por diseño, trece son revisiones, casi todas sistemáticas o metaanálisis, con alguna de alcance y una narrativa; cinco son ensayos clínicos aleatorizados; seis, estudios cuasiexperimentales o con medidas antes y después, y cinco, estudios observacionales. A ellos hay que sumar dieciséis guías de práctica clínica, consensos o herramientas de prescripción y once textos normativos, alertas de seguridad o estadísticas oficiales. Nueve de los estudios empíricos se hicieron en España (Canarias, Cataluña, Gipuzkoa, Andalucía, Lleida y datos nacionales), y los demás vienen del Reino Unido, Alemania, Australia, Canadá y Estados Unidos. La Tabla 6 resume las características y el hallazgo principal de los estudios y revisiones sobre sujeciones, consumo, daño, alternativas y papel enfermero. Los programas de reducción y los ensayos de retirada se detallan aparte, en la Tabla 9, con la variable que midió cada uno y su seguimiento. La revisión narrativa de Hilmer y Gnjidic sobre la carga anticolinérgica figura en la Tabla 8, y las guías y la normativa en las Tablas 2 y 3.

**Tabla 6.** *Características y hallazgos principales de los estudios y revisiones sobre sujeciones, consumo de psicofármacos, daño, alternativas y papel enfermero.*

| Autor (año), país | Diseño y nivel | Muestra y ámbito | Intervención o exposición | Resultado principal |
|---|---|---|---|---|
| Estévez-Guerra et al. (2017), España | Transversal multicéntrico (IV) | 920 residentes, 9 centros de Canarias, observación directa | Sujeciones físicas | 84,9 % con alguna sujeción (36,6 % sin contar barandillas); motivo en el 94,2 %: prevenir caídas |
| Köpke et al. (2012), Alemania | ECA por conglomerados (II) | 36 residencias, 4.449 residentes | Intervención multicomponente basada en guía, con enfermeras de referencia | Sujeciones 31,5 % a 22,6 % a 6 meses (OR 0,71); sin cambios en caídas ni psicofármacos |
| Möhler et al. (2023), Cochrane | Revisión sistemática (I) | 11 estudios, 19.003 residentes con demencia | Intervenciones para reducir sujeciones físicas | Mínima sujeción: RR 0,86 de sujeción y 0,54 de cinturón; sin efecto en caídas ni psicofármacos |

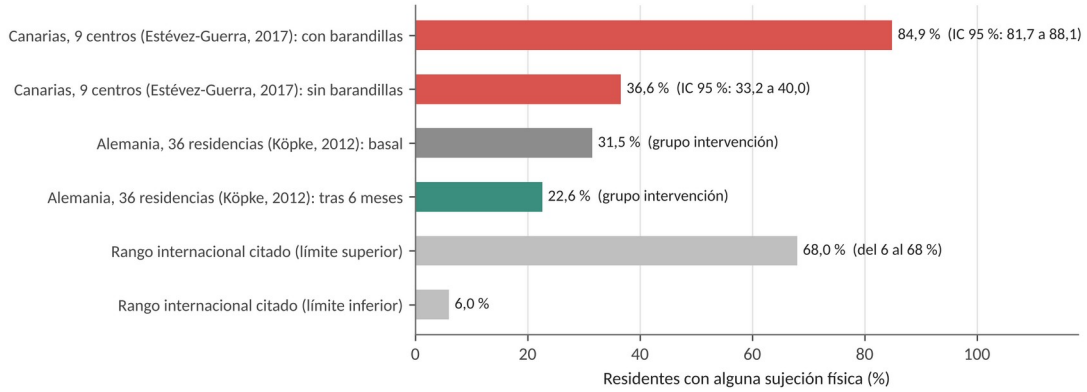
| Autor (año), país | Diseño y nivel | Muestra y ámbito | Intervención o exposición | Resultado principal |
|---|---|---|---|---|
| Hofmann y Hahn (2014), Suiza | Revisión sistemática (I) | 9 estudios en residencias | Características de residentes sujetos | Sujeción asociada a bajo nivel cognitivo y funcional; consecuencias: dependencia, caídas, úlceras, incontinencia |
| Evans et al. (2003), Australia | Revisión sistemática (I) | 12 estudios observacionales | Lesiones por dispositivos de sujeción | La sujeción puede aumentar muerte, caídas, lesiones graves y duración del ingreso |
| Ubeda et al. (2012), España | Descriptivo (IV) | 81 residentes, una residencia de Lleida | Revisión farmacéutica con STOPP/START y Beers | 5 fármacos por residente; 48 % con criterio STOPP y 25 % Beers; benzodiacepinas largas las más frecuentes |
| Sánchez-Soblechero et al. (2025), España | Cohorte retrospectiva nacional (IV) | Base BIFAP, demencia incidente 2002-2018 | Prescripción de antipsicóticos | Del 12,6 % al 23,8 %; quetiapina del 0,2 % al 16,4 %; el doble que en el Reino Unido |
| Mar et al. (2024), España | Observacional poblacional (IV) | 221.777 mayores de 60 años de Gipuzkoa | Factores asociados al uso de antipsicóticos | Residencia OR 12,61; demencia OR 10,18; nivel socioeconómico bajo OR 1,60 |
| Schneider et al. (2005), EE. UU. | Metaanálisis de ECA (I) | 15 ensayos, 5.110 pacientes con demencia | Antipsicóticos atípicos frente a placebo | Mortalidad 3,5 % frente a 2,3 %; OR 1,54 |
| Maust et al. (2015), EE. UU. | Casos y controles retrospectivo (IV) | 90.786 veteranos con demencia | Antipsicóticos y otros psicofármacos | NNH a 180 días: haloperidol 26, risperidona 27, olanzapina 40, quetiapina 50 |
| Seppala et al. (2018), Países Bajos | Metaanálisis (I) | 248 estudios en mayores de 60 años | Psicofármacos y caídas | OR de caída: antipsicóticos 1,54; antidepresivos 1,57; benzodiacepinas 1,42 (largas 1,81) |
| Tannenbaum et al. (2014), Canadá | ECA por conglomerados (II), comunitario | 303 usuarios crónicos de benzodiacepinas de 65 a 95 años | Folleto educativo directo al paciente (EMPOWER) | 27 % suspendió la benzodiacepina frente al 5 % (NNT 4); evidencia indirecta |
| Abraha et al. (2017), Europa | Revisión de revisiones (I) | 38 revisiones, 129 estudios primarios | Intervenciones no farmacológicas para los SPCD | Musicoterapia y técnicas de manejo conductual eficaces; gran variabilidad |
| Bibi et al. (2025), Italia | Revisión sistemática (I) | 14 estudios en centros de larga estancia | Factores de variación en el uso de antipsicóticos | Más enfermeras tituladas y mejor formación se asocian a menor uso |
| Barbuiani et al. (2025), Italia | Revisión de alcance (I) | 28 estudios, todos los ámbitos | Papel enfermero en la desprescripción | Revisión de medicación, detección de efectos adversos, educación y monitorización; eficacia de lo liderado por enfermería |
| Vaismoradi et al. (2024), internacional | Revisión integradora (I) | 32 estudios en larga estancia | Participación enfermera en la desprescripción | Monitorizar, comunicar y educar; obstáculos: conocimientos, confianza y presencia en el equipo |

Fuente: elaboración propia. Nivel de evidencia según el diseño: I, revisiones sistemáticas y metaanálisis; II, ensayos aleatorizados; III, estudios cuasiexperimentales; IV, observacionales. ECA: ensayo clínico aleatorizado; NNH: número necesario para dañar; NNT: número necesario para tratar; OR: odds ratio; RR: riesgo relativo; SPCD: síntomas psicológicos y conductuales de la demencia.

## 5.2 Sujeción física y consumo de psicofármacos en las residencias españolas: lo que se mide y lo que no

Entre los residentes canarios que observaron Estévez-Guerra y colaboradores, el 84,9 % llevaba alguna sujeción física y el 36,6 % alguna distinta de las barandillas completas; el cinturón en la silla aparecía en el 26,9 % y en la cama en el 9,9 % (17). La Figura 4 pone esas cifras al lado de la prevalencia basal de las residencias alemanas del ensayo de Köpke, en torno al 31 %, y del 22,6 % que ese mismo ensayo alcanzó después de la intervención (27), y añade el rango internacional del 6 al 68 % que citan los propios autores canarios (17). Hasta en la comparación más favorable la distancia es grande.

**Figura 4.** *Prevalencia de sujeciones físicas en residencias: España frente a referencias internacionales.*




Fuente: elaboración propia a partir de Estévez-Guerra et al. (2017) y Köpke et al. (2012). El rango internacional procede de la revisión citada en el primero.

La contención farmacológica no se ha medido, y eso ya es un resultado. No hay ningún estudio español que cuantifique cuántos residentes reciben un psicofármaco con finalidad restrictiva, porque para saberlo habría que revisar, pauta por pauta, con qué indicación se prescribió, para qué se sigue dando y cómo se registra. El consumo sí se mide. Y es alto. En la línea basal del programa CHROME, de los 107 residentes con demencia seguidos hasta el final, un 42,7 % tenía pautado un neuroléptico atípico, un 25,2 % una benzodiacepina de vida media larga y un 47,7 % un hipnótico (39). En las siete residencias catalanas de Massot Mesquida, 240 de los 250 residentes con demencia llevaban al menos tres meses con algún psicofármaco, entendido en sentido amplio

(todo el grupo N de la clasificación ATC salvo anestésicos y analgésicos), y entre todos sumaban 636 prescripciones, 2,71 por persona (35). En las cinco residencias andaluzas del protocolo Los Filabres la media era de 2,38, el 72,5 % de los residentes tomaba un antipsicótico y el 30,9 % tenía alguna pauta a demanda (20). A escala poblacional la tendencia va hacia arriba. La prescripción de antipsicóticos a personas con demencia se duplicó entre 2002 y 2018 pese a las dos alertas de la AEMPS, y el fármaco que explica esa subida es la quetiapina (48), que es también el antipsicótico más usado en Gipuzkoa, donde vivir en una residencia multiplica por doce la probabilidad de que se prescriba uno de estos fármacos (33).

Ninguna de estas cifras es una prevalencia de contención farmacológica, ni sirve para calcularla. Entre quienes toman un antipsicótico hay personas con una indicación clara y una revisión reciente, y con los datos publicados no se las puede separar de aquellas a las que se les da para que no deambulen. El camino indirecto de la sujeción física tampoco vale: que en un centro abunden los cinturones habla de su cultura de cuidado, no de cuántos comprimidos se dan con ese mismo fin. El único trabajo español que examinó la contención química pauta a pauta fue la auditoría externa del programa CHROME, y solo comunica el resultado final, ninguna al terminar (39).

Hay dos detalles de estos estudios con interés directo para la práctica enfermera. En el protocolo Los Filabres, los residentes con alguna pauta a demanda pasaron del 30,9 % al 1,4 % en doce meses (20), y en HALT los autores comprobaron que retirar el antipsicótico pautado no se compensó con más antipsicóticos ni benzodiacepinas “si precisa” (10). El otro detalle es la variabilidad entre centros. En Canarias, la prevalencia de sujeciones fue del 70,3 al 96,6 % según el centro, con residentes comparables (17), y la revisión de Bibi y colaboradores atribuye las diferencias en el uso de antipsicóticos a la cultura prescriptora, a la formación y a la dotación de enfermeras tituladas, más que a las características de los residentes (8). Dicho de otro modo, el uso de sujeciones y de antipsicóticos parece depender más de quién cuida que de a quién se cuida. Esa es la razón de más peso para revisar las pautas una a una. En la Tabla 7 se ordena qué mide cada tipo de dato y hasta dónde permite llegar.

**Tabla 7.** *Qué mide cada tipo de dato disponible y qué permite afirmar sobre la contención farmacológica.*

| Tipo de dato | Cómo se obtiene | Lo que hay en los estudios españoles incluidos | Qué permite afirmar |
|---|---|---|---|
| Sujeción física | Observación directa de los dispositivos que lleva cada residente | 84,9 % con alguna sujeción en nueve centros canarios; 36,6 % sin contar las barandillas | Describe la cultura de contención del centro. No informa sobre el uso de fármacos con ese fin |
| Consumo de psicofármacos | Hoja de tratamiento o base de datos de prescripción: residentes tratados, fármacos por persona, dosis | Antipsicóticos en la demencia del 12,6 % al 23,8 % entre 2002 y 2018; 2,71 y 2,38 psicofármacos por residente en dos programas; neuroléptico atípico en el 42,7 % y antipsicótico en el 72,5 % de los residentes de otros dos | Mide la exposición y, con ella, el riesgo de efectos adversos. Incluye tratamientos indicados y revisados |
| Prescripción potencialmente inapropiada | Criterios explícitos (STOPP, Beers) aplicados a la hoja de tratamiento | 48 % de los residentes con algún criterio STOPP y 25 % con algún criterio Beers en una residencia de Lleida | Señala qué pautas revisar primero. Incumplir un criterio no prueba una finalidad restrictiva |
| Contención farmacológica | Revisión caso a caso de la indicación, la finalidad y el registro de cada pauta | Sin datos de prevalencia. Las auditorías externas de CHROME no hallaron ninguna al final del programa | Es el único dato que permitiría hablar de personas contenidas con fármacos, y no está disponible |

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 17, 20, 35, 39, 48 y 53.

## 5.3 El daño de los psicofármacos, sea cual sea su finalidad

En la Tabla 8 está reunido lo que la evidencia ha cuantificado sobre los riesgos de los psicofármacos en personas mayores; las Figuras 5 y 6 representan los dos resultados más sólidos, que son la mortalidad y las caídas. Se trata de riesgos de la exposición al fármaco. Los estudios de los que salen incluyeron a personas mayores tratadas con ellos, muchas por síntomas de la demencia, sin distinguir con qué finalidad se prescribieron, así que valen para cualquier residente que tome uno, esté bien indicado o no.

**Tabla 8.** *Daños cuantificados asociados al uso de psicofármacos y de sujeciones en personas mayores.*

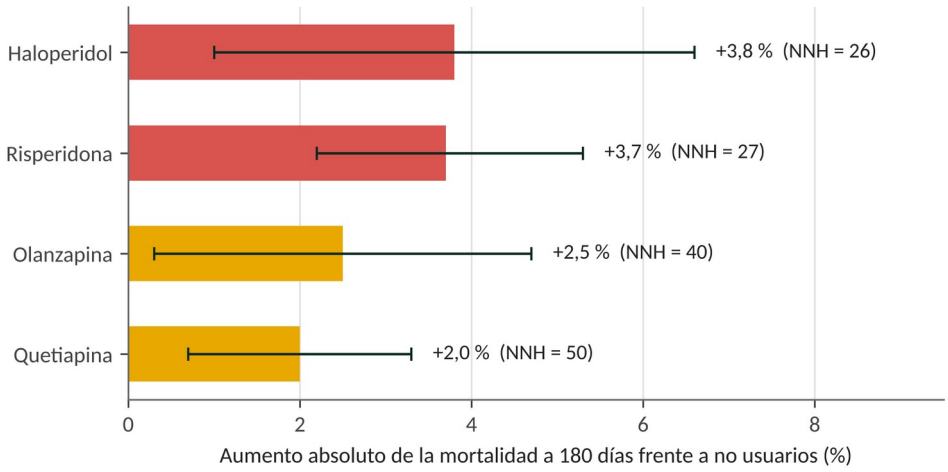
| Exposición | Resultado | Magnitud del efecto | Fuente y nivel |
|---|---|---|---|
| Antipsicóticos atípicos (10-12 semanas) en demencia | Mortalidad | 3,5 % frente a 2,3 % con placebo; OR 1,54 (IC 95 %: 1,06 a 2,23) | Schneider et al. (2005), metaanálisis (I) |
| Olanzapina en ancianos con demencia | Mortalidad e ictus | Mortalidad 3,5 % frente a 1,5 %; ictus 1,3 % frente a 0,4 % | AEMPS 2004/03, alerta de seguridad |
| Antipsicóticos clásicos frente a atípicos en demencia | Mortalidad | Razón de tasas ajustada 1,26 a 1,55 | AEMPS 2008/19, a partir de Gill et al. |

| Exposición | Resultado | Magnitud del efecto | Fuente y nivel |
|---|---|---|---|
| Antipsicóticos (180 días) en demencia | Mortalidad absoluta añadida | Haloperidol +3,8 % (NNH 26); risperidona +3,7 % (27); olanzapina +2,5 % (40); quetiapina +2,0 % (50) | Maust et al. (2015), casos y controles (IV) |
| Continuar el antipsicótico frente a retirarlo (Alzheimer institucionalizado) | Supervivencia | A 36 meses, 30 % frente a 59 %; HR de muerte 0,58 a favor de la retirada | Ballard et al. (2009), ECA (II) |
| Antipsicóticos | Caídas | OR 1,54 (IC 95 %: 1,28 a 1,85) | Seppala et al. (2018), metaanálisis (I) |
| Benzodiacepinas (global; acción larga; acción corta) | Caídas | OR 1,42; 1,81; 1,27 | Seppala et al. (2018), metaanálisis (I) |
| Antidepresivos (global; ISRS; tricíclicos) | Caídas | OR 1,57; 2,02; 1,41 | Seppala et al. (2018), metaanálisis (I) |
| Tres o más fármacos activos sobre el SNC | Caídas y fracturas | Recomendación fuerte de evitar; evidencia alta | Beers 2023, guía (V) |
| Fármacos con efecto anticolinérgico acumulado | Deterioro cognitivo, pérdida funcional, caídas | Efecto acumulativo; reversible en parte al desprescribir | Hilmer y Gnjidic (2022), revisión (V) |
| Sujeción física | Dependencia, caídas, úlceras, incontinencia, muerte | Asociación consistente en estudios observacionales; magnitud no cuantificada | Hofmann y Hahn (2014); Evans et al. (2003), revisiones (I) |

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 2, 3, 4, 6, 18, 22, 23, 36, 49 y 51. HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza; NNH: número necesario para dañar; OR: odds ratio; SNC: sistema nervioso central.

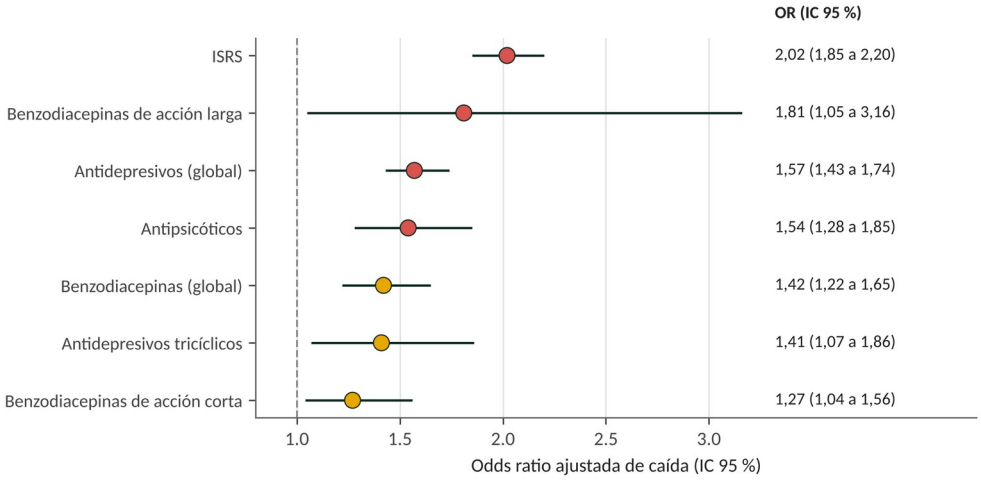
Un número necesario para dañar de 26 quiere decir que, por cada 26 personas con demencia tratadas con haloperidol durante seis meses, muere una que no habría muerto (36). No es un daño marginal, ni se limita a una molécula. La quetiapina, que la práctica española ha convertido en el antipsicótico por defecto, tiene el número necesario para dañar más alto de los cuatro, pero sigue siendo medible, y la relación dosis-respuesta observada en los atípicos sugiere que cada escalón de dosis cuenta (36,48). El dato que más me ha llamado la atención es el de las caídas. El motivo que justifica una sujeción física en el 94,2 % de los casos (17) es también el efecto adverso más constante de las benzodiacepinas y de los antipsicóticos (4,51). Se sujeta a la persona para que no se caiga y, si encima se la seda, se le está dando justo lo que más la hace caer.

**Figura 5.** *Aumento absoluto de la mortalidad a 180 días y número necesario para dañar con cada antipsicótico en personas con demencia.*




Fuente: elaboración propia a partir de Maust et al. (2015). Las barras de error representan el intervalo de confianza del 95 %.

**Figura 6.** *Riesgo de caída asociado a los principales grupos de psicofármacos en personas mayores.*




Fuente: elaboración propia a partir de Seppala et al. (2018). ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

## 5.4 Desprescribir psicofármacos: eficacia y seguridad, estudio a estudio

Si el daño está claro, la pregunta que decide es otra: si retirar esos fármacos es seguro para la persona. Los ensayos de retirada dicen que sí, aunque con más condiciones de las

que suelen citarse. La revisión Cochrane de Van Leeuwen y colaboradores reunió diez ensayos, ocho de ellos en residencias, con 632 personas con demencia que llevaban al menos tres meses tomando un antipsicótico, y no pudo combinar sus datos porque cada ensayo medía el resultado con una escala distinta. Con evidencia de baja calidad, concluye que la retirada produce poca o ninguna diferencia en los síntomas neuropsiquiátricos globales, en los efectos adversos, en la calidad de vida y en la cognición. Hubo más recaídas en los dos ensayos que solo incluían a personas que habían respondido al fármaco, y los análisis por subgrupos sugieren que quienes parten de síntomas graves pueden empeorar. Ningún ensayo evaluó los síntomas de retirada, las caídas no se recogieron de manera sistemática y sobre la mortalidad los datos no alcanzan (55). La guía canadiense lo convierte en una recomendación operativa: desprescribir en quienes llevan al menos tres meses con los síntomas estabilizados o sin respuesta a un ensayo adecuado (9). Solo el DART-AD, de los estudios incluidos, tomó la mortalidad como variable principal. A los doce meses la supervivencia era del 70 % entre quienes siguieron con el antipsicótico y del 77 % entre quienes pasaron a placebo, y la diferencia se fue ampliando después, hasta el 30 % frente al 59 % a los tres años (6). Es un resultado muy citado, y tiene sus límites: una muestra de 165 personas, un seguimiento largo hecho por teléfono y unos fármacos entre los que no estaba la quetiapina que hoy domina la prescripción española.

Los programas aplicados en residencias no miden lo mismo, así que sus resultados no se pueden sumar ni poner en fila de mayor a menor. Reducir el porcentaje de residentes tratados, reducir el número de prescripciones y reducir la dosis son tres resultados distintos. La Tabla 9 recoge de cada estudio el diseño, las personas incluidas, la variable medida, el seguimiento y los límites. En el texto los agrupo según lo que midieron.

HALT y CHROME contaron cuántos residentes seguían con el fármaco. En HALT, enfermeras de 23 residencias australianas reclutaron a 139 residentes que llevaban al menos tres meses con un antipsicótico pautado, sin enfermedad psicótica primaria ni síntomas conductuales graves. A los doce meses esa cifra había bajado un 81,7 %, sin que el fármaco se sustituyera por otros ni aumentaran de forma significativa las dosis “si precisa” (10). En el centro canario de CHROME, entre los 107 residentes con demencia

que estuvieron en las cinco mediciones de dos años, la proporción con un neuroléptico atípico pasó del 42,7 % al 18,7 % (39). Massot Mesquida y su equipo contaron prescripciones. Una sesión de revisión conjunta entre atención primaria y la residencia las redujo de 636 a 458, un 28 %, y la media por residente pasó de 2,71 a 1,95 al mes y a 2,01 a los seis meses, cuando ya se había reintroducido el 12 % de lo retirado (35); el análisis de coste-utilidad que vino después calificó la intervención de dominante, es decir, más eficaz y más barata que la atención habitual (34). Los Filabres aportó las dos medidas: una media que bajó de 2,38 a 1,57 psicofármacos por residente en doce meses y una proporción de residentes con antipsicótico que pasó del 72,5 % al 40,5 % (20). Weeks y colaboradores midieron dosis. En 45 residencias españolas, la dosis diaria equivalente de antipsicótico bajó entre un 23 % y un 28 % respecto a controles emparejados, a las dos y a las cuatro semanas, sin más muertes, caídas ni sujeciones físicas (56). Una media que pasa de casi tres fármacos a dos no dice cuántas personas dejaron de tomarlos, y una dosis más baja reduce la exposición aunque la persona siga con el fármaco.

**Tabla 9.** *Programas de reducción de psicofármacos y ensayos de retirada: diseño, personas incluidas, variable medida, seguimiento y límites.*

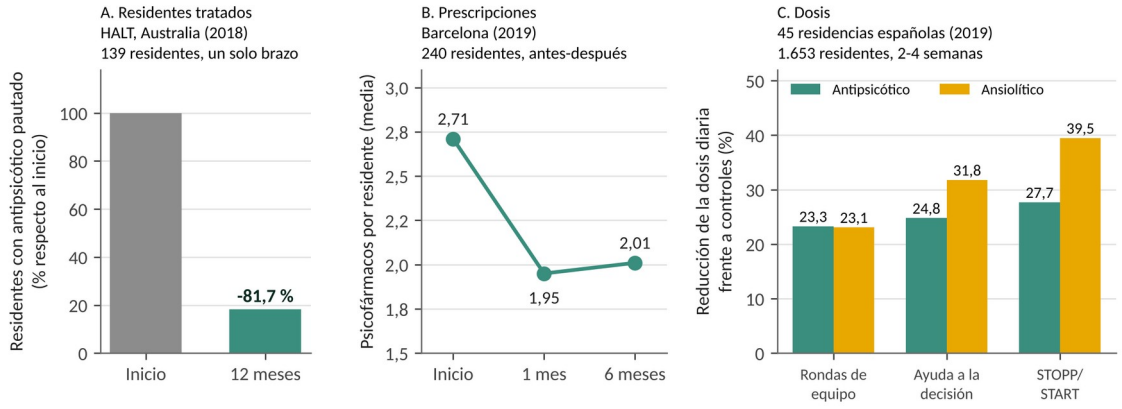
| Estudio, país e intervención | Diseño y seguimiento | Personas incluidas | Qué midió y qué obtuvo | Seguridad observada y límites |
|---|---|---|---|---|
| **Resultado medido como porcentaje de residentes tratados** | | | | |
| HALT (Brodaty et al., 2018), Australia. Protocolo de desprescripción, formación del equipo y enfermeras promotoras | Longitudinal de un solo brazo con medidas repetidas (III); 12 meses | 139 residentes de 23 residencias con antipsicótico pautado desde hacía 3 meses o más; excluidos psicosis primaria y SPCD graves | Residentes que siguen con antipsicótico pautado: 81,7 % menos (IC 95 %: 72,4 a 89,0) | Sin cambios en SPCD, caídas, ingresos ni cognición; sin sustitución ni más “si precisa”. Muestra seleccionada, sin grupo control |
| CHROME (Muñiz et al., 2020), Gran Canaria. Formación en diagnóstico y prescripción, con auditoría externa | Observacional prospectivo en un solo centro (III); 24 meses, cinco mediciones semestrales | 288 residentes (edad media 81,6 años; 77,4 % con demencia); resultados de los 107 con demencia presentes en las cinco mediciones | Residentes con cada fármaco: neuroléptico atípico 42,7 % a 18,7 %; benzodiacepina de vida media larga 25,2 % a 6,5 %; hipnótico 47,7 % a 12,1 % | Caídas de 67,3 a 32,7 por 100 residentes-año; auditorías sin sujeción física ni química. Un centro, sin grupo control, análisis de quienes completaron |
| EPCentCare (Richter et al., 2019), Alemania. Atención centrada en la persona | ECA por conglomerados (II); 12 meses | 1.153 residentes de 37 residencias; los médicos de ambos grupos recibieron revisiones de la medicación | Residentes con al menos un antipsicótico: 44,6 % a 44,8 % (intervención) frente a 39,8 % a 33,3 % (control) | Sin reducción; diferencia final del 11,4 % a favor del grupo control |

| Estudio, país e intervención | Diseño y seguimiento | Personas incluidas | Qué midió y qué obtuvo | Seguridad observada y límites |
|---|---|---|---|---|
| **Resultado medido como número de prescripciones** | | | | |
| Revisión por consenso (Massot Mesquida et al., 2019 y 2021), Cataluña. Sesión conjunta de atención primaria y residencia, con guía consensuada | Cuasiexperimental antes-después, multicéntrico (III); medidas al mes y a los 6 meses | 240 residentes con demencia de 7 residencias, con uno o más psicofármacos desde hacía 3 meses o más; excluidos trastornos mentales graves; edad media 87 años, 75 % mujeres | Prescripciones de psicofármacos (grupo N de la ATC salvo anestésicos y analgésicos): 636 a 458 (28 % menos). Media por residente: 2,71 a 1,95 (1 mes) y 2,01 (6 meses). Antipsicóticos: 49,7 % menos | Reintroducción del 12 % a los 6 meses. Sin grupo control; solo registra cambios de medicación, no síntomas ni caídas. Coste-utilidad favorable en un modelo a 12 meses |
| Los Filabres (García Carricondo et al., 2026), Andalucía. Formación del personal e intervención no farmacológica sobre necesidades no cubiertas (modelo de Henderson) | Longitudinal antes-después de un solo brazo (III); 12 meses, con medidas a los 0, 6 y 12 | 204 residentes con demencia o deterioro cognitivo moderado o grave de 5 residencias; edad media 84,5 años; 148 completaron | Media de psicofármacos por residente: 2,38 a 1,57. Residentes con antipsicótico: 72,5 % a 40,5 %; con ansiolítico: 77,0 % a 23,0 %; con pauta a demanda: 30,9 % a 1,4 % | Residentes con algún síntoma relevante (NPI): 93,1 % a 35,8 %; sin acontecimientos adversos atribuidos. Sin grupo control ni evaluación enmascarada; posible efecto Hawthorne |
| **Resultado medido como dosis** | | | | |
| Tres métodos (Weeks et al., 2019), 45 residencias españolas. Rondas de equipo, criterios STOPP/START o ayuda a la decisión | Observacional retrospectivo con controles emparejados por puntuación de propensión (III); 2 y 4 semanas | 1.653 residentes de 70 a 99 años con demencia y antipsicótico, ansiolítico o antidepresivo; 606 intervenidos | Reducción de la dosis diaria equivalente frente a controles. Antipsicótico: 23,3 %, 24,8 % y 27,7 % según el método. Ansiolítico: 23,1 %, 31,8 % y 39,5 % | Más suspensiones; sin más muertes, caídas ni sujeciones físicas. Seguimiento muy corto; no aleatorizado |
| **Otra variable principal** | | | | |
| WHELD (Ballard et al., 2018), Reino Unido. Atención centrada en la persona, interacción social y revisión de antipsicóticos | ECA por conglomerados (II); 9 meses | 847 residentes con demencia de 69 residencias; 553 completaron | Calidad de vida (DEMQOL-Proxy): diferencia media de 2,54 puntos. Antipsicóticos (variable secundaria): uso bajo y estable, sin cambio | Mejoran la agitación y los síntomas neuropsiquiátricos. Efectos pequeños; la revisión de antipsicóticos no implicó a atención primaria |
| DART-AD (Ballard et al., 2009), Reino Unido. Sustituir el antipsicótico por placebo | ECA de retirada controlado con placebo (II); 12 meses, con comprobación de supervivencia hasta 54 meses | 165 personas con Alzheimer en centros de cuidados (128 iniciaron el tratamiento); tioridazina, clorpromazina, haloperidol, trifluoperazina o risperidona | Mortalidad a 12 meses (variable principal): supervivencia del 70 % al continuar frente al 77 % con placebo. A 24 meses, 46 % frente a 71 %; a 36 meses, 30 % frente a 59 % | HR 0,58 a favor de la retirada en todo el periodo. Muestra pequeña; seguimiento largo por teléfono; no incluye quetiapina |
| **Revisiones sistemáticas** | | | | |
| Van Leeuwen et al. (2018), Cochrane. Retirada frente a continuación del antipsicótico | Revisión sistemática de 10 ECA (I); sin metaanálisis porque las medidas de resultado eran distintas | 632 personas con demencia y antipsicótico desde hacía 3 meses o más; 8 ensayos en residencias | Éxito de la retirada y síntomas, con escalas diferentes: poca o ninguna diferencia en síntomas globales (7 ensayos, 519 participantes) | Más recaídas en quienes habían respondido (2 ensayos). Calidad baja; síntomas de retirada no evaluados, caídas no recogidas de forma sistemática, mortalidad incierta |

| Estudio, país e intervención | Diseño y seguimiento | Personas incluidas | Qué midió y qué obtuvo | Seguridad observada y límites |
|---|---|---|---|---|
| Lühnen et al. (2023), Cochrane. Intervenciones psicosociales para reducir antipsicóticos | Revisión sistemática de 5 ECA por conglomerados (I); síntesis narrativa | 8.342 residentes en 120 conglomerados | Un ensayo mide días de uso (6,3 menos por 100 residentes-día); cuatro, porcentaje de residentes tratados, con resultados de signo contrario. Efecto incierto (certeza baja) | Poca o ninguna diferencia en caídas, ingresos no programados y urgencias (certeza alta) |
| Kua et al. (2019). Desprescripción de cualquier fármaco, con o sin revisión de la medicación | Metaanálisis de 41 ECA (I) | 18.408 residentes de 60 años o más | Residentes con medicación potencialmente inapropiada: 59 % menos (OR 0,41; IC 95 %: 0,19 a 0,89) | Con revisión de la medicación: mortalidad OR 0,74 y residentes con caídas OR 0,76. No es específico de psicofármacos |

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 5, 6, 10, 20, 28, 32, 34, 35, 39, 46, 55 y 56. Los resultados no son comparables entre bloques porque se expresan en unidades distintas. Entre paréntesis, nivel de evidencia según el diseño, como en la Tabla 6. ECA: ensayo clínico aleatorizado; HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza; NPI: Neuropsychiatric Inventory; OR: odds ratio; SPCD: síntomas psicológicos y conductuales de la demencia.

**Figura 7.** *Tres programas, tres medidas: residentes con antipsicótico pautado (HALT), psicofármacos por residente (Barcelona) y dosis diaria (45 residencias españolas).*




Fuente: elaboración propia a partir de Brodaty et al. (2018), Massot Mesquida et al. (2019) y Weeks et al. (2019). Las escalas de los tres paneles no son comparables entre sí.

Esas tres medidas aparecen una junto a otra en la Figura 7, cada una con su escala. Hay dos estudios españoles que añaden algo que los internacionales no enseñan con tanta claridad. En el centro del programa CHROME, la reducción de psicofármacos fue de la mano de un descenso de las caídas, de 67,3 a 32,7 por cada 100 residentes y año, y al final dos auditorías independientes no encontraron ninguna sujeción, ni física ni química (39). El protocolo Los Filabres buscó la causa de la conducta antes de tratar el síntoma. Una vez identificadas las necesidades no cubiertas de cada residente, ordenadas según el modelo de Virginia Henderson, la proporción con algún síntoma conductual relevante

pasó del 93,1 % al 35,8 %, y los psicofármacos bajaron con ella (20). Ni uno ni otro tienen grupo control. El metaanálisis de Kua y colaboradores sí reúne ensayos aleatorizados, 41 con 18.408 residentes, aunque sobre desprescripción en general. Las intervenciones redujeron un 59 % los residentes con medicación potencialmente inapropiada, y las que se guiaban por una revisión de la medicación se asociaron a una mortalidad un 26 % menor y a un 24 % menos de residentes con caídas (28).

No todo señala en la misma dirección. WHELD, cuya variable principal era la calidad de vida, la mejoró, pero no redujo unos antipsicóticos que ya eran bajos al empezar. En EPCentCare, su adaptación alemana, la proporción de residentes tratados se quedó a los doce meses por encima de la del grupo control, cuyos médicos también habían recibido revisiones de la medicación (5,46). La revisión Cochrane de Lühnen, con cinco ensayos por conglomerados de signo contrario, considera incierto el efecto de las intervenciones psicosociales sobre la prescripción de antipsicóticos. Sí concluye, con certeza alta, que no modifican las caídas, los ingresos ni las visitas a urgencias (32).

Así que lo que puede afirmarse sobre la seguridad de la retirada depende de a quién se incluyó y de cómo se midió. Los residentes de HALT eran, como reconocen sus autores, una muestra seleccionada: estables, sin psicosis primaria ni síntomas graves, y sin grupo de comparación. En ellos no cambiaron los síntomas conductuales, ni las caídas, ni las hospitalizaciones, ni la cognición (10). El programa catalán solo registró los cambios de medicación, sin síntomas ni caídas, y su indicador de seguridad es indirecto, esa reintroducción del 12 % en personas con una edad media de 87 años (35). Weeks observó únicamente de dos a cuatro semanas, un plazo en el que no caben las recaídas tardías (56). Las cifras de CHROME corresponden a quienes estuvieron en las cinco mediciones y dejan fuera a los que no completaron los dos años (39). En Los Filabres terminaron el año 148 de los 204 residentes; quienes aplicaban el protocolo eran también quienes evaluaban, y no puede descartarse que parte de la mejoría se deba a saberse observados (20). Leídos todos juntos, estos estudios respaldan la retirada gradual y vigilada en residentes estables, sin enfermedad psicótica primaria ni síntomas graves. Para quien respondió con claridad al fármaco, o parte de síntomas graves,

aconsejan prudencia. Y dejan sin contestar qué pasa con los síntomas de retirada y con la mortalidad a largo plazo con los fármacos que se usan hoy.

## 5.5 Las alternativas: qué funciona cuando no se da el comprimido

Desprescribir sin ofrecer nada a cambio sería dejar solos a la persona y al equipo. La revisión de revisiones de Abraha y colaboradores, con 38 revisiones sistemáticas y 129 estudios primarios, sitúa la musicoterapia y las técnicas de manejo conductual como las intervenciones de eficacia más consistente sobre los síntomas conductuales, aunque con una gran variabilidad en cómo se definen y se aplican (1). La Comisión Lancet de 2024 recomienda, ante la agitación o la psicosis, evaluar y tratar primero las causas (el dolor y el malestar entre las primeras), ensayar después estrategias no farmacológicas y solo entonces discutir con la persona y su familia el uso de un antipsicótico, a la dosis más baja y durante el menor tiempo posible (31). El método DICE ordena ese trabajo en cuatro verbos, describir la conducta con precisión, investigar sus causas, crear un plan a medida y evaluar el resultado (26). La Tabla 10 resume estas intervenciones desde una mirada práctica: qué puede hacer la enfermera de una residencia con los medios que tiene.

**Tabla 10.** *Intervenciones no farmacológicas para los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia con mejor respaldo.*

| Intervención | Evidencia | Cómo se aplica desde enfermería en una residencia |
|---|---|---|
| Valoración estructurada de la conducta (método DICE) | Recomendado por NICE y por la Comisión Lancet como paso previo a cualquier fármaco | Describir qué pasa, cuándo y con quién; buscar dolor, infección, estreñimiento, retención, sueño, ruido, soledad; proponer un plan y fijar cuándo se evalúa |
| Tratamiento del dolor y de las causas somáticas | Primera causa señalada por la Comisión Lancet; encaja con el enfoque de necesidades no cubiertas de Los Filabres | Escalas de dolor para personas que no lo verbalizan, analgesia pautada y revisión del estreñimiento y la micción antes de pedir un “si precisa” |
| Musicoterapia y estimulación sensorial | Eficacia consistente en la revisión de revisiones de Abraha | Música personalizada en los momentos de mayor agitación (aseo, atardecer), masaje de manos, luz y ruido controlados |
| Técnicas de manejo conductual | Eficacia consistente en Abraha; núcleo de los programas HALT y CHROME | Formación del equipo en desescalada verbal, rutinas predecibles, validación, no confrontar; registro de lo que funciona con cada persona |

| Intervención | Evidencia | Cómo se aplica desde enfermería en una residencia |
|---|---|---|
| Atención centrada en la persona y actividades con sentido | Mejora de calidad de vida y agitación en WHELD; no reduce por sí sola los antipsicóticos | Historia de vida, actividades que la persona elige, interacción social diaria de al menos una hora; combinar con revisión de la medicación |
| Formación del personal con revisión de la medicación | Núcleo de HALT y de CHROME; la Cochrane de Lühnen considera incierto el efecto de lo psicosocial por sí solo y atribuye a la revisión de la medicación el resultado favorable de un ensayo | Sesiones breves y repetidas, con casos propios; una enfermera referente del programa en cada planta |

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 1, 10, 20, 26, 31, 32, 39 y 40.

## 5.6 Lo que hacen las enfermeras en los programas que funcionan

He leído los programas preguntándome qué hace la enfermera en cada uno de ellos, y aparece un patrón que ningún estudio describe entero pero que todos contienen a trozos. En HALT, las enfermeras identificaron y reclutaron a los residentes candidatos, se formaron en manejo no farmacológico y actuaron como promotoras del cambio en cada centro (10). En el programa catalán, la enfermera de la residencia se sentó en la sesión de revisión con el médico y el farmacéutico y aportó lo que solo ella sabe: cómo duerme la persona, cómo come, cuándo se agita, qué pasó la última vez que se le bajó una dosis (35). En el ensayo alemán sobre sujeciones físicas, lo que distinguió a la intervención fue formar enfermeras de referencia que después sostuvieron el cambio en su unidad (27). Para que todo eso ocurra hace falta, antes, una plantilla con enfermeras tituladas, que es el factor que la revisión de Bibi ya había señalado (8). Estas funciones están ordenadas en la Tabla 11.

**Tabla 11.** *Funciones de la enfermería identificadas en los programas y revisiones incluidos.*

| Función | Dónde aparece | En qué consiste |
|---|---|---|
| Detectar candidatos | HALT; CHROME; criterios STOPP/START | Revisar la hoja de tratamiento buscando psicofármacos sin indicación registrada, pautas a demanda usadas a diario y tratamientos de más de tres meses sin revisión |
| Valorar la conducta y sus causas | DICE; Los Filabres; Comisión Lancet | Describir el síntoma, buscar dolor y necesidades no cubiertas, usar escalas (NPI-NH, CMAI) y transmitir al equipo lo observado en los turnos |
| Proponer y participar en la revisión | Programa catalán; rondas de equipo de Weeks; revisiones de Barbuiani y Vaismoradi | Llevar los casos a la sesión conjunta con argumentos explícitos; comunicar lo que sabe de la persona y de su familia |

| Función | Dónde aparece | En qué consiste |
|---|---|---|
| Informar a la persona y a la familia | EMPOWER (evidencia indirecta); guía canadiense; Ley 41/2002 | Explicar los riesgos y el plan de retirada en un lenguaje claro; recoger la voluntad y preferencias; dejar constancia |
| Vigilar la retirada | LESS-CHRON; guías canadienses; lista de McInerney | Buscar los diez signos de alarma (caídas, somnolencia diurna, rigidez, confusión, inestabilidad, mareo, hipotensión postural, menor autocuidado, inquietud, sequedad de boca) y los síntomas de retirada; reevaluar a las 1-2 semanas y a las 6 |
| Aplicar la alternativa no farmacológica | HALT; CHROME; Los Filabres; WHELD | Poner en marcha y mantener el plan conductual, sensorial o de actividad acordado; formar a auxiliares |
| Registrar y medir | Instrucción 1/2022; Acuerdo SAAD; Defensor del Pueblo | Documentar motivo, alternativas, consentimiento, dosis y revisiones; alimentar los indicadores del centro |
| Sostener el cambio | Enfermeras de referencia de Köpke; promotoras de HALT; revisión de Bibi | Actuar como referente del programa en la planta; mantener la formación y la cultura de mínima sujeción |

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 7, 8, 9, 10, 19, 20, 26, 27, 29, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 52, 54 y 56. CMAI: Cohen-Mansfield Agitation Inventory; NPI-NH: Neuropsychiatric Inventory, versión para residencias.

Las dos revisiones específicas sobre el papel enfermero coinciden en el diagnóstico y también en el obstáculo. Para Barbuiani y colaboradores, la aportación enfermera consiste en revisar la medicación, detectar efectos adversos e interacciones, educar y monitorizar; las intervenciones dirigidas por enfermería, solas o en equipo, reducen la medicación potencialmente inapropiada (7). Vaismoradi y colaboradores añaden lo que frena a las enfermeras en la larga estancia, que es la falta de conocimientos y de confianza, y no tener voz allí donde se decide (54). El consenso internacional de McInerney y colaboradores aporta algo muy concreto: una lista de diez signos y síntomas de efectos adversos de los psicofármacos que habría que vigilar de forma proactiva, empezando por las caídas recientes y la somnolencia diurna (37).

## 5.7 Del requisito normativo al registro enfermero

El último bloque de resultados cruza los requisitos de los tres documentos normativos más recientes con el registro enfermero. La Instrucción 1/2022, el Acuerdo de acreditación de 2022 y la guía del Defensor del Pueblo de 2026 exigen para cualquier contención el mismo núcleo de requisitos, desde la prescripción individualizada hasta el registro trazable, como muestra la Tabla 12 (15,19,45). Todo ese aparato, sin embargo, está pensado para la contención mecánica. La farmacológica entra en la definición y se queda fuera de los instrumentos. Los listados que pide la Fiscalía recogen el tipo y los puntos de sujeción, el Defensor del Pueblo detalla cada cuánto hay que observar a una

persona inmovilizada, y un antipsicótico mantenido dos años con una orden “si precisa” no figura en ningún listado. Puede que no deba figurar, si responde a una indicación vigente. No debería ocurrir, en cambio, que nadie lo haya comprobado. Por su posición, la enfermería es quien mejor puede provocar esa comprobación: registrando cada “si precisa” con su motivo, la alternativa intentada, la dosis, la hora y la respuesta, y señalando al equipo las pautas crónicas sin indicación ni fecha de revisión para que se decida, caso a caso, si son un tratamiento o una contención.

**Tabla 12.** *Requisitos normativos para toda contención y su traducción a la revisión y al registro enfermero de los psicofármacos.*

| Requisito | Lo exigen | Cómo se traduce a la revisión y al registro de un psicofármaco pautado a demanda o sin indicación vigente |
|---|---|---|
| Prescripción facultativa individualizada; prohibición de órdenes genéricas | Instrucción 1/2022; Acuerdo SAAD; Defensor del Pueblo | Ninguna pauta “si agitación” sin síntoma diana, finalidad escrita, dosis máxima diaria y fecha de revisión; cada administración a demanda registrada con motivo y hora |
| Último recurso: alternativas intentadas y documentadas | Instrucción 1/2022; Acuerdo SAAD; Comité de Bioética | Antes de administrar un “si precisa”, anotar la valoración DICE y la medida no farmacológica aplicada y su resultado |
| Consentimiento explícito, para cada situación, no genérico ni diferido | Ley 41/2002; Comité de Bioética; Instrucción 1/2022; Acuerdo SAAD | Información a la persona o a su representante sobre riesgos (mortalidad, caídas) y plan de retirada; constancia de la voluntad y preferencias (Ley 8/2021) |
| Temporalidad: duración mínima y plazo máximo | Instrucción 1/2022 (minutos, no horas); Defensor del Pueblo | Antipsicótico en SPCD con revisión obligatoria a las 6 semanas y a los 3 meses; benzodiacepina con plan de retirada desde la cuarta semana |
| Supervisión continua y reevaluación | Instrucción 1/2022 (nota 4: constantes, higiene, hidratación, contacto verbal); Defensor del Pueblo | Vigilancia de sedación, hipotensión, deglución, ingesta y los diez signos de alarma; registro en cada turno mientras dure la pauta |
| Registro trazable y revisión como indicador de calidad | Instrucción 1/2022; Acuerdo SAAD (historial de la persona); Defensor del Pueblo | Indicadores mensuales: residentes con antipsicótico sin indicación, con benzodiacepina más de 4 semanas, consumo de pautas a demanda, caídas |
| Plan de atención libre de sujeciones y reducción progresiva | Acuerdo SAAD (antes del 30/6/2025); Defensor del Pueblo (8.5) | Incluir en el plan del centro la revisión sistemática de psicofármacos y la ruta enfermera de desprescripción |
| Comunicación a la Fiscalía | Acuerdo SAAD (obligatoria); Instrucción 1/2022 (listado periódico) | Incorporar al listado los psicofármacos en los que la revisión confirme una finalidad de contención, con la misma información que las sujeciones mecánicas |

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 11, 15, 19, 29, 30 y 45.

# 6 Discusión

## 6.1 Consensos, controversias y vacíos de la evidencia

Si tuviera que resumir lo que he aprendido con estos 56 documentos diría dos cosas. Una, que el daño de los psicofármacos en la persona mayor está bien medido y que su retirada parece segura en residentes estables y vigilados. Otra, que de la contención farmacológica propiamente dicha no hay ni una sola cifra española. La Tabla 13 ordena ese balance en consensos, controversias y vacíos.

**Tabla 13.** *Síntesis de la revisión: consensos, controversias y vacíos de conocimiento.*

| Ámbito | Consenso | Controversia o matiz | Vacío de conocimiento |
|---|---|---|---|
| Concepto de contención química | Usar un psicofármaco con finalidad restrictiva es una sujeción y exige los mismos requisitos que la mecánica | Consumir un psicofármaco no equivale a estar contenido; la frontera depende de la finalidad y de la revisión, que los registros no recogen | No existe un instrumento validado para medir la prevalencia de contención química en residencias españolas |
| Magnitud | El uso de sujeciones físicas y de antipsicóticos en España es alto y superior al de países vecinos | Son cifras de regiones y centros concretos, muy variables entre centros, y no permiten estimar la contención farmacológica | Faltan datos nacionales recientes sobre sujeciones físicas y sobre pautas “si precisa” |
| Daño | Más mortalidad, más caídas y más deterioro funcional con antipsicóticos y benzodiacepinas | El riesgo varía por molécula y dosis; la quetiapina es menos dañina pero no inocua | Efecto a largo plazo de la polifarmacia psicotrópica sobre la calidad de vida medida con escalas |
| Eficacia y seguridad de la retirada | En residentes estables durante tres meses, retirar el antipsicótico produce poca o ninguna diferencia en los síntomas | Quienes respondieron con claridad o tienen síntomas graves pueden recaer; la evidencia es de calidad baja y procede de muestras seleccionadas | Síntomas de retirada, caídas y mortalidad con los fármacos actuales; ensayos de retirada de benzodiacepinas e hipnóticos en residencias |
| Qué intervención funciona | Los programas con revisión de la medicación reducen el consumo, cada uno en su medida: residentes tratados, prescripciones o dosis | La atención centrada en la persona mejora la vida del residente pero no redujo los antipsicóticos; el efecto de lo psicosocial es incierto | Medidas de resultado comunes para comparar programas; componentes imprescindibles y coste en residencias españolas de tamaño medio |
| Papel de la enfermería | Monitorizar, comunicar, educar y sostener el cambio; más enfermeras tituladas, menos antipsicóticos | Los programas describen el papel enfermero de forma fragmentaria y sin medirlo como variable | Ensayos de desprescripción liderados por enfermería en residencias; indicadores enfermeros de revisión de psicofármacos |
| Marco normativo | La atención libre de sujeciones químicas es un derecho reconocido y un requisito de acreditación | Los instrumentos de control están diseñados para la contención mecánica | Grado real de implantación de los planes libres de sujeciones tras el plazo de junio de 2025 |

Fuente: elaboración propia.

El primer consenso es conceptual, y es también el más incómodo. Las definiciones de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, del Comité de Bioética y de la Fiscalía

coinciden en que lo que convierte un psicofármaco en sujeción es la finalidad restrictiva (11,12,19). Pero la finalidad no está escrita en ninguna parte, ni se deduce de una cifra de consumo. Que falte un síntoma diana, que la dosis lleve meses sin revisarse o que el "si precisa" se dé a diario son señales para sentarse a revisar la pauta, no pruebas de que sea una contención. Creo que ese es el hallazgo central de la revisión. Sabemos cuántos residentes llevan un cinturón y cuántos toman un antipsicótico, pero no cuántos están contenidos con fármacos, porque nadie ha mirado esas pautas con esa pregunta en la cabeza. Y como no se ha mirado, tampoco aparece en los listados que pide la Fiscalía ni en los indicadores de los planes libres de sujeciones.

Sobre el daño hay aún menos discusión, y la evidencia está entre las más sólidas de todo el trabajo. Un metaanálisis de ensayos, un estudio de casos y controles con más de 90.000 personas, un ensayo de retirada con seguimiento a tres años y un metaanálisis de 248 estudios sobre caídas apuntan todos en la misma dirección (6,36,49,51). Con esa evidencia y dos alertas regulatorias, cuesta entender que la prescripción de antipsicóticos en la demencia se haya duplicado en España en poco más de quince años (48). Los autores de ese estudio proponen alertas mejor diseñadas y estrategias nacionales de demencia. Yo añadiría que la quetiapina ha ocupado el sitio de los fármacos sobre los que se avisó: la alerta de 2004 nombraba moléculas concretas (olanzapina, risperidona), la de 2008 extendió el aviso a los antipsicóticos clásicos, y en la práctica se cambió de molécula en lugar de replantear la prescripción (2,3). Una nota regulatoria cambia qué se prescribe, pero no parece que cambie cuánto, y eso, por lo que he leído, solo lo consigue la revisión sistemática de la medicación.

La principal controversia está en qué funciona, y en parte nace de comparar cosas que no son comparables. Los resultados de WHELD y de EPCentCare, donde la atención centrada en la persona no redujo los antipsicóticos, se leen a veces como un fracaso de ese modelo (5,46). Pero admiten otra lectura: cambiar la cultura de cuidado y revisar la medicación son dos trabajos distintos, y hay que hacer los dos. Los programas que redujeron el consumo, desde HALT y el catalán hasta los tres métodos de Weeks y CHROME, tenían un componente de revisión de la prescripción y alguien responsable de que esa revisión ocurriera (10,35,39,56); Los Filabres llegó a lo mismo por otro camino, el

de las necesidades no cubiertas (20). Ahora bien, no redujeron lo mismo. Que haya un 81,7 % menos de residentes con antipsicótico, que la media baje de 2,71 a 2,01 fármacos o que la dosis sea un 23 % menor son logros de alcance distinto para la persona, y ninguno de ellos mide cuántas pautas dejaron de tener una finalidad restrictiva. La revisión Cochrane de Lühnen pide la misma cautela, ya que, con ensayos de signo contrario, considera incierto el efecto de las intervenciones psicosociales sobre la prescripción (32). El metaanálisis de Kua añade el dato que más debería pesar en una dirección de residencia: cuando la desprescripción se guía por una revisión de la medicación, la mortalidad es menor y se caen menos residentes (28).

La seguridad de la retirada merece una línea aparte, porque es el argumento que más se oye en contra: “si le quitamos la risperidona se va a poner peor”. La respuesta honesta es que depende de a quién. Para el residente estable, sin psicosis primaria ni síntomas graves, que es el perfil de HALT y el de la recomendación canadiense, ese miedo tiene poco apoyo en los datos (9,10). Para quien respondió con claridad al fármaco o parte de síntomas graves, la revisión Cochrane de Van Leeuwen le da la razón a la prudencia (55). Quedan preguntas que ningún estudio contesta bien, porque casi todos los programas carecen de grupo control, los seguimientos van de dos semanas a dos años y los ensayos no evaluaron los síntomas de retirada. En Barcelona hubo que reintroducir a los seis meses el 12 % de lo retirado (35). Yo no lo contaría como un fracaso, sino como la señal de que la retirada se estaba vigilando. En la práctica quiere decir que toda retirada es una prueba, con fecha de revisión y con la vuelta atrás prevista.

## 6.2 Por qué la desprescripción es un cuidado

Este trabajo se inscribe en la línea del impacto de la polimedicación en la calidad de vida, y creo que ahora puedo contestar a esa pregunta con cierta precisión. A una persona mayor institucionalizada, la polimedicación psicotrópica le quita cosas muy concretas. Años de vida, si se mira la supervivencia del DART-AD. Pasos, con las caídas que cuantifica Seppala. La capacidad de vestirse y de comer sola, que es la pérdida funcional que Hofmann y Hahn describen para las sujeciones y Hilmer para la carga anticolinérgica. Y presencia, quizá la forma más elemental de calidad de vida, la de estar despierta cuando

viene la familia (6,22,23,51). Cuando WHELD mide la calidad de vida con una escala y la ve mejorar al cambiar la manera de cuidar, está midiendo algo muy parecido a eso (5).

Visto así, desprescribir deja de ser un asunto farmacológico que la enfermería mira desde fuera. Es una intervención sobre la autonomía, la movilidad, el sueño, la alimentación y la relación con los demás, es decir, sobre el terreno que la enfermería valora y cuida en cada turno. Las dos revisiones sobre el papel enfermero lo dicen con todas las letras: las intervenciones lideradas por enfermería reducen la medicación inapropiada (7,54). A eso se añade un argumento ético que desde la Ley 8/2021 ya no puede esquivarse. Si quien presta apoyo tiene que actuar según la voluntad, deseos y preferencias de la persona (30), la enfermera que la ve a diario está mejor situada que nadie para saber qué preferiría si pudiera elegir entre dormir doce horas o pasear por el jardín. Y queda el argumento económico, que tampoco es menor: la intervención catalana fue más eficaz y más barata que la atención habitual (34).

## 6.3 Una ruta enfermera para una residencia real

La propuesta con la que cierro este trabajo no pretende inventar nada. Recoge lo que hacen los programas que funcionan y lo ordena para que una enfermera de residencia pueda empezar el lunes. La Figura 8 la resume en seis pasos, en un ciclo que arranca de nuevo con cada revisión; las Tablas 14 y 15 añaden lo que hace falta para ponerla en marcha, una pauta orientativa de retirada y un cuadro de indicadores.

El primer paso es detectar, y basta con una revisión mensual de la hoja de tratamiento con tres preguntas: si hay algún psicofármaco sin indicación escrita, si alguna pauta a demanda se está dando más de dos veces por semana y si algún antipsicótico o benzodiacepina lleva más de tres meses sin que nadie haya escrito nada sobre él. Esa revisión la respaldan los criterios STOPP/START v3, en su versión española, con los códigos D5, D8, D9, D10, D15, D16, K1 y K2, que resumo en el Anexo B, y los criterios Beers añaden la alarma de los tres fármacos activos sobre el sistema nervioso central (4,16,41). De ahí no sale una lista de contenciones, sino una lista de pautas que alguien tiene que revisar: con qué indicación se prescribieron, con qué finalidad se siguen dando y cómo se registran. Después viene valorar con el método DICE, antes de proponer nada,

porque muchas de las conductas que terminan motivando un antipsicótico tienen una causa que se trata de otra manera, y el protocolo Los Filabres enseña hasta qué punto (20,26). El tercer paso, proponer, consiste en llevar el caso a la sesión conjunta con el médico y el farmacéutico, como en el modelo catalán, y en informar a la persona y a la familia de los riesgos y del plan, como piden la Ley 41/2002 y la guía canadiense. En EMPOWER esa información bastó para que uno de cada cuatro mayores dejara su benzodiacepina (9,29,35,52).

**Figura 8.** *Ruta enfermera de revisión y desprescripción de psicofármacos en residencias.*




Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 9, 10, 19, 26, 35, 37, 41, 43 y 47.

Retirar es el cuarto paso, despacio y de un fármaco en uno. La Tabla 14 recoge las pautas de los algoritmos canadienses: en los antipsicóticos, reducciones del 25 al 50 % de la dosis cada una o dos semanas hasta suspender; en las benzodiacepinas y los fármacos Z, del 25 % cada dos semanas, más lentas hacia el final y con días sin fármaco si es posible (9,43). Luego toca vigilar. Estar atenta a los síntomas de retirada, al insomnio de rebote, a la agitación, a las caídas, a las constantes y al sueño, con una reevaluación a la semana o a las dos semanas y otra a las seis, que es el plazo que NICE fija para revisar cualquier antipsicótico en la demencia. Los diez signos de McInerney dicen qué hay que mirar en

cada turno (37,40). Los criterios LESS-CHRON aportan aquí algo que no he visto en ninguna otra herramienta: para cada fármaco, qué variable vigilar y durante cuánto tiempo (47). Y el sexto paso, registrar lo que la norma exige con la lista de comprobación del Anexo C y medirlo en los indicadores del centro, me parece la única manera de que la revisión de los psicofármacos entre en el plan libre de sujeciones que el Acuerdo de acreditación obliga a tener (19,45).

**Tabla 14.** *Pauta orientativa de retirada gradual de psicofármacos y vigilancia enfermera, según los algoritmos de las guías canadienses.*

| Grupo | Cuándo plantear la retirada | Pauta orientativa de reducción | Qué vigilar y cuándo | Qué hacer si reaparecen los síntomas |
|---|---|---|---|---|
| Antipsicóticos en SPCD | Tras al menos 3 meses con los síntomas estabilizados o sin respuesta a un ensayo adecuado; siempre si no hay síntoma diana registrado | Reducir el 25-50 % de la dosis cada 1-2 semanas hasta suspender; más despacio si la dosis es alta o el tratamiento muy prolongado | Agitación, alucinaciones, agresividad, sueño, caídas, rigidez; cada 1-2 semanas durante la retirada y a las 6 semanas | Descartar causa tratable (DICE); si persiste riesgo real, volver a la dosis anterior más baja eficaz y fijar nueva fecha de revisión |
| Benzodiacepinas y fármacos Z | En toda persona mayor de 65 años, sea cual sea la duración; prioridad si hay caídas, deterioro cognitivo o uso superior a 4 semanas | Reducir el 25 % cada 2 semanas; al final, reducciones del 12,5 % y días sin fármaco; nunca suspender de golpe | Insomnio de rebote, ansiedad, irritabilidad, sudoración, molestias digestivas, confusión; cada 1-2 semanas | Mantener el escalón durante más tiempo antes de bajar; reforzar higiene del sueño y medidas no farmacológicas; no volver a la dosis inicial |
| Hipnóticos sedantes y antihistamínicos de primera generación | Si se usan para dormir en personas con demencia o con carga anticolinérgica alta | Reducción progresiva similar a la de las benzodiacepinas; sustituir por rutinas de sueño y luz diurna | Sueño nocturno, siestas diurnas, sequedad de boca, retención urinaria, estreñimiento | Revisar causas del insomnio (dolor, nicturia, ruido) antes de cualquier fármaco |

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 9, 37, 40, 43 y 47. SPCD: síntomas psicológicos y conductuales de la demencia. Las pautas son orientativas y deben individualizarse con el médico prescriptor.

**Tabla 15.** *Indicadores propuestos para el seguimiento del uso de psicofármacos y de su revisión en el plan de atención libre de sujeciones de una residencia.*

| Indicador | Cálculo | Frecuencia | Fuente del dato | Referencia o meta orientativa |
|---|---|---|---|---|
| Residentes con antipsicótico sin indicación ni finalidad registradas | Residentes con antipsicótico pautado y sin síntoma diana ni diagnóstico que lo justifique / residentes con antipsicótico × 100 | Mensual | Hoja de tratamiento y plan de cuidados | Tender a 0 %; en CHROME los residentes con neuroléptico atípico pasaron del 42,7 % al 18,7 % |
| Residentes con antipsicótico más de 12 semanas sin revisión | Criterio STOPP D15 y D5 / residentes con antipsicótico × 100 | Mensual | Hoja de tratamiento | 0 %; NICE exige revisión al menos cada 6 semanas |

| Indicador | Cálculo | Frecuencia | Fuente del dato | Referencia o meta orientativa |
|---|---|---|---|---|
| Residentes con benzodiacepina o fármaco Z más de 4 semanas | Criterio STOPP D8, D10 y D11 / total de residentes × 100 | Mensual | Hoja de tratamiento | Descendente; en CHROME los residentes con benzodiacepina larga pasaron del 25,2 % al 6,5 % |
| Pautas a demanda administradas | Administraciones “si precisa” de psicofármacos por 100 residentes y mes, con motivo registrado | Mensual | Registro de administración | Descendente; cada administración con motivo y alternativa intentada |
| Residentes con tres o más fármacos activos sobre el SNC | Criterio Beers / total de residentes × 100 | Trimestral | Hoja de tratamiento | Descendente |
| Caídas | Caídas por 100 residentes y mes (y con lesión) | Mensual | Registro de incidencias | No debe aumentar al desprescribir; en CHROME bajaron de 67,3 a 32,7 por 100 residentes-año |
| Retiradas completadas y reintroducciones | Fármacos retirados / propuestos; reintroducidos a los 6 meses / retirados | Semestral | Actas de la sesión de revisión | Reintroducción en torno al 12 % como en el programa catalán |
| Sujeciones físicas | Residentes con alguna sujeción distinta de barandillas / total × 100 | Mensual | Registro de contenciones | Descendente; no debe subir al reducir psicofármacos |
| Comunicación a la Fiscalía | Psicofármacos incluidos en el listado periódico / pautas en las que la revisión confirma una finalidad de contención | Según periodicidad del centro | Listado de contenciones | 100 % |

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 4, 19, 35, 39, 40, 41 y 45. Los indicadores miden consumo, adecuación y revisión; ninguno equivale por sí solo a una prevalencia de contención farmacológica. SNC: sistema nervioso central.

Esta ruta pide dos cosas que no siempre existen: tiempo de enfermería y un sitio en la mesa donde se revisa la medicación. El tiempo lo decide la dirección del centro, y la revisión de Bibi y colaboradores da un argumento para pedirlo, porque allí donde hay más enfermeras tituladas se prescriben menos antipsicóticos (8). El sitio en la mesa depende, en parte, de nosotras. Según la revisión de Vaismoradi, a las enfermeras las frena la falta de conocimientos y de confianza (54). Esa carencia, al menos, es de las que un trabajo como este puede ayudar a reducir, aunque sea un poco.

## 6.4 Limitaciones

Este trabajo tiene las limitaciones propias de su diseño, y alguna más. Como es una revisión narrativa, la selección de los documentos la he hecho yo sola y sin ninguna herramienta formal de riesgo de sesgo, de modo que la clasificación por niveles de evidencia es una orientación y no una evaluación de calidad. La búsqueda principal se

limitó a PubMed. La completé con fuentes institucionales y en bola de nieve, pero es posible que se me hayan quedado fuera estudios españoles publicados en revistas no indexadas, sobre todo de enfermería. Los datos españoles de prevalencia proceden de regiones y centros concretos (Canarias, Cataluña, Gipuzkoa, Andalucía, Lleida) y no permiten dar una cifra nacional; varios de los programas españoles no tienen grupo control, como advierten sus propios autores. Son datos de consumo y de sujeción física, y de ninguno de ellos puede deducirse cuántas personas están sometidas a contención farmacológica. Los programas, a su vez, miden su resultado en unidades distintas y con seguimientos que van de dos semanas a dos años, por lo que he renunciado a resumirlos en una cifra común. Tampoco he podido consultar el texto completo de algún algoritmo de retirada, así que las pautas de la Tabla 14 están reconstruidas a partir de las guías y de sus resúmenes y deben leerse como orientativas. La ruta y los indicadores que propongo no se han pilotado en ninguna residencia. Son una síntesis razonada de lo que ha funcionado en otros sitios, no un protocolo validado.

## 6.5 Líneas futuras

De los vacíos de la Tabla 13 salen por lo menos tres trabajos que me gustaría ver hechos. El primero sería un estudio que revisara pauta por pauta, en una muestra de residencias españolas, la indicación, la finalidad y el registro de cada psicofármaco, porque solo así se tendría una cifra de contención farmacológica que hoy no existe. Hace falta, en segundo lugar, un ensayo de desprescripción de psicofármacos liderado por enfermería, con la ruta de este trabajo como intervención y con unos resultados acordados de antemano (residentes tratados, dosis, pautas a demanda, caídas), para que por fin se pudiera comparar con otros. Habría que evaluar también hasta qué punto se han implantado los planes de atención libre de sujeciones después del plazo de junio de 2025, y si incluyen la revisión de los psicofármacos. Y queda, más modesto pero más al alcance, pilotar los indicadores de la Tabla 15 en una residencia y comprobar si pueden calcularse con los registros que ya existen.

# 7 Conclusiones

Primera. La contención química es el uso de un psicofármaco, normalmente un antipsicótico o una benzodiacepina, con la finalidad de controlar la conducta o la movilidad, sin una indicación clínica específica o más allá del tiempo necesario. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, el Comité de Bioética de España y la Fiscalía General del Estado la equiparan a la sujeción mecánica, y desde 2022 la atención libre de sujeciones químicas es un derecho de las personas atendidas en el sistema de dependencia y un requisito de acreditación. La diferencia con un tratamiento está en la finalidad, la indicación y la revisión, no en el fármaco, así que consumir psicofármacos no equivale a estar contenido. Una pauta “si agitación” que se administra de forma rutinaria no es por sí misma una sujeción, pero obliga a revisar su indicación, su finalidad y su registro.

Segunda. No hay ningún dato español sobre cuántas personas están sometidas a contención farmacológica, y las cifras disponibles no permiten calcularlo. Lo que describen es un contexto que justifica la revisión. En el único estudio multicéntrico español incluido, el 84,9 % de los residentes llevaba alguna sujeción física; la prescripción de antipsicóticos a personas con demencia se duplicó entre 2002 y 2018 pese a dos alertas regulatorias, y vivir en una residencia multiplica por doce la probabilidad de recibir uno. Los daños de esos fármacos, se den con el fin que se den, están cuantificados: según el fármaco, entre 26 y 50 personas tratadas durante seis meses por cada muerte añadida; odds de caída entre 1,4 y 2 veces mayores con benzodiacepinas, antipsicóticos y antidepresivos; y una pérdida funcional y de presencia que, en la práctica, es pérdida de calidad de vida.

Tercera. Reducir los psicofármacos en una residencia es posible, y cada programa lo ha demostrado con su propia medida. En HALT había, a los doce meses, un 81,7 % menos de residentes con antipsicótico pautado; el programa catalán bajó la media de psicofármacos por residente de 2,71 a 2,01 a los seis meses, y en las 45 residencias estudiadas por Weeks la dosis diaria de antipsicótico se redujo entre un 23 % y un 28 % respecto a los controles en dos a cuatro semanas. Son resultados que no se pueden

sumar ni comparar entre sí. En cuanto a la seguridad, la evidencia respalda la retirada gradual en residentes estables desde hace al menos tres meses y sin síntomas graves. En ellos no empeoran los síntomas ni la cognición y, donde se midieron, no aumentaron las caídas ni los ingresos. Quienes respondieron con claridad al fármaco o tienen síntomas graves pueden recaer; los ensayos no evaluaron los síntomas de retirada y casi ningún programa tiene grupo control. La supervivencia a tres años del ensayo DART-AD, del 59 % al retirar frente al 30 % al continuar, apunta en la misma dirección, con una muestra pequeña y sin quetiapina entre los fármacos estudiados. La atención centrada en la persona mejoró la calidad de vida en un ensayo, pero no redujo el consumo en ninguno de los dos que la evaluaron.

Cuarta. En todos esos programas la enfermera está presente, aunque pocas veces aparezca en el título. Detecta a los candidatos, valora la conducta y sus causas, aporta a la revisión lo que ha observado en los turnos, informa a la persona y a la familia, vigila la retirada, aplica la alternativa no farmacológica y sostiene el cambio en la planta. Las revisiones sobre el papel enfermero lo resumen en monitorizar, comunicar y educar, y la dotación de enfermeras tituladas se asocia a un uso menor de antipsicóticos. A partir de ahí propongo una ruta en seis pasos, una pauta orientativa de retirada y nueve indicadores para incorporar la revisión de los psicofármacos al plan de atención libre de sujeciones de una residencia.

Termino donde empecé, en el vasito de las diez de la noche. Después de esta revisión sigo sin poder decir si aquella quetiapina era una sujeción. Sé que hay un criterio STOPP que la señala, que tiene un número necesario para dañar y que existe una pauta para retirarla despacio si no se sostiene. Y sé qué habría que mirar para salir de dudas: con qué indicación se pautó, para qué se sigue dando y cómo se registra. Solo falta que alguien se siente a revisarla. Me gustaría que ese alguien fuera, cada vez más, una enfermera.

# Referencias bibliográficas

1. Abraha I, Rimland JM, Trotta FM, Dell'Aquila G, Cruz-Jentoft A, Petrovic M, et al. Systematic review of systematic reviews of non-pharmacological interventions to treat behavioural disturbances in older patients with dementia. The SENATOR-OnTop series. BMJ Open. 2017;7(3):e012759. doi:10.1136/bmjopen-2016-012759

2. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Nota informativa de la AEMPS sobre antipsicóticos clásicos: aumento de mortalidad en pacientes ancianos con demencia. Ref. 2008/19, de 28 de noviembre de 2008. Madrid: AEMPS; 2008. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2008/ni_2008-19_antipsicoticos/

3. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Nuevos datos de seguridad sobre los antipsicóticos olanzapina y risperidona en el tratamiento de pacientes ancianos con psicosis o trastornos de conducta asociados a demencia. Nota informativa 2004/03, de 13 de marzo de 2004. Madrid: AEMPS; 2004.

4. American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-81. doi:10.1111/jgs.18372

5. Ballard C, Corbett A, Orrell M, Williams G, Moniz-Cook E, Romeo R, et al. Impact of person-centred care training and person-centred activities on quality of life, agitation, and antipsychotic use in people with dementia living in nursing homes: a cluster-randomised controlled trial. PLoS Med. 2018;15(2):e1002500. doi:10.1371/journal.pmed.1002500

6. Ballard C, Hanney ML, Theodoulou M, Douglas S, McShane R, Kossakowski K, et al. The dementia antipsychotic withdrawal trial (DART-AD): long-term follow-up of a randomised placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2009;8(2):151-7. doi:10.1016/S1474-4422(08)70295-3

7. Barbuiani G, Terzoni S, Caruso R, Cilluffo S, Pasina L, Lusignani M. Nurses' role in deprescribing for older adults: a scoping review. Int J Nurs Stud. 2025;174:105274. doi:10.1016/j.ijnurstu.2025.105274

8. Bibi R, Panella M, Saada S, Payedimarri AB, Conti A, Russotto S, et al. Factors associated with the variation in drug prescription of antipsychotics in long-term care facilities: a systematic review. BMC Geriatr. 2025;26(1):33. doi:10.1186/s12877-025-06558-5

9. Bjerre LM, Farrell B, Hogel M, Graham L, Lemay G, McCarthy L, et al. Deprescribing antipsychotics for behavioural and psychological symptoms of dementia and insomnia: evidence-based clinical practice guideline. Can Fam Physician. 2018;64(1):17-27.

10. Brodaty H, Aerts L, Harrison F, Jessop T, Cations M, Chenoweth L, et al. Antipsychotic deprescription for older adults in long-term care: the HALT study. J Am Med Dir Assoc. 2018;19(7):592-600.e7. doi:10.1016/j.jamda.2018.05.002

11. Comité de Bioética de España. Consideraciones éticas y jurídicas sobre el uso de contenciones mecánicas y farmacológicas en los ámbitos social y sanitario. Madrid: Comité de Bioética de España; 2016. Disponible en: https://comitedebioetica.isciii.es/wp-content/uploads/2023/10/Informe-Contenciones-CBE.pdf

12. Comité Interdisciplinar de Sujeciones. Documento de consenso sobre sujeciones mecánicas y farmacológicas. Madrid: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; 2014.

13. Consejo de Europa. Recomendación CM/Rec(2014)2 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la promoción de los derechos humanos de las personas mayores. Estrasburgo: Consejo de Europa; 2014. Disponible en: https://rm.coe.int/09000016805c649f

14. Curtin D, Gallagher P, O'Mahony D. Deprescribing in older people approaching end-of-life: development and validation of STOPPFrail version 2. Age Ageing. 2021;50(2):465-71. doi:10.1093/ageing/afaa159

15. Defensor del Pueblo. Buenas prácticas en las contenciones mecánicas. Madrid: Defensor del Pueblo; 2026. Disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2026/06/Contenciones_mecanicas.pdf

16. Delgado-Silveira E, Molina Mendoza MD, Montero-Errasquín B, Muñoz García M, Rodríguez Espeso EA, Vélez-Díaz-Pallarés M, et al. Versión en español de los criterios STOPP/START 3. Avances en la detección de la prescripción inapropiada de medicamentos en personas mayores. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2023;58(5):101407. doi:10.1016/j.regg.2023.101407

17. Estévez-Guerra GJ, Fariña-López E, Núñez-González E, Gandoy-Crego M, Calvo-Francés F, Capezuti EA. The use of physical restraints in long-term care in Spain: a multi-center cross-sectional study. BMC Geriatr. 2017;17(1):29. doi:10.1186/s12877-017-0421-8

18. Evans D, Wood J, Lambert L. Patient injury and physical restraint devices: a systematic review. J Adv Nurs. 2003;41(3):274-82. doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02501.x

19. Fiscalía General del Estado. Instrucción 1/2022, de 19 de enero, sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad. Boletín Oficial del Estado, núm. 36, de 11 de febrero de 2022, p. 18260-79. BOE-A-2022-2221.

20. García Carricondo I, García Carricondo AR, Romero del Rey R, Alarcón-Rodríguez R. Evaluation of the "Los Filabres" protocol on behavioral and psychological symptoms of dementia and psychotropic drug use in nursing home residents. Healthcare (Basel). 2026;14(13):1934. doi:10.3390/healthcare14131934

21. Gavilán-Moral E, Villafaina-Barroso A, Jiménez-de Gracia L, Gómez Santana MC. Ancianos frágiles polimedicados: ¿es la deprescripción de medicamentos la salida? Rev Esp Geriatr Gerontol. 2012;47(4):162-7. doi:10.1016/j.regg.2012.01.003

22. Hilmer SN, Gnjidic D. The anticholinergic burden: from research to practice. Aust Prescr. 2022;45(4):118-20. doi:10.18773/austprescr.2022.031

23. Hofmann H, Hahn S. Characteristics of nursing home residents and physical restraint: a systematic literature review. J Clin Nurs. 2014;23(21-22):3012-24. doi:10.1111/jocn.12384

24. Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población 2026-2076. Nota de prensa de 17 de junio de 2026. Madrid: INE; 2026. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/Prensa/PROP20262076.htm

25. Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Boletín Oficial del Estado, núm. 96, de 21 de abril de 2008, p. 20648-59. BOE-A-2008-6963.

26. Kales HC, Gitlin LN, Lyketsos CG. Assessment and management of behavioral and psychological symptoms of dementia. BMJ. 2015;350:h369. doi:10.1136/bmj.h369

27. Köpke S, Mühlhauser I, Gerlach A, Haut A, Haastert B, Möhler R, et al. Effect of a guideline-based multicomponent intervention on use of physical restraints in nursing homes: a randomized controlled trial. JAMA. 2012;307(20):2177-84. doi:10.1001/jama.2012.4517

28. Kua CH, Mak VSL, Huey Lee SW. Health outcomes of deprescribing interventions among older residents in nursing homes: a systematic review and meta-analysis. J Am Med Dir Assoc. 2019;20(3):362-72.e11. doi:10.1016/j.jamda.2018.10.026

29. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Boletín Oficial del Estado, núm. 274, de 15 de noviembre de 2002. BOE-A-2002-22188.

30. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Boletín Oficial del Estado, núm. 132, de 3 de junio de 2021. BOE-A-2021-9233.

31. Livingston G, Huntley J, Liu KY, Costafreda SG, Selbæk G, Alladi S, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet. 2024;404(10452):572-628. doi:10.1016/S0140-6736(24)01296-0

32. Lühnen J, Richter T, Calo S, Meyer G, Köpke S, Möhler R. Psychosocial interventions for reducing antipsychotic medication in care home residents. Cochrane Database Syst Rev. 2023;8(8):CD008634. doi:10.1002/14651858.CD008634.pub3

33. Mar J, Zubiagirre U, Larrañaga I, Soto-Gordoa M, Mar-Barrutia L, González-Pinto A, et al. Disparities by socioeconomic status and diagnosis of dementia in the prescribing of antipsychotics in a real-world data population over 60 years of age. J Alzheimers Dis. 2024;100(2):645-55. doi:10.3233/JAD-240004

34. Massot Mesquida M, Folkvord F, Seda G, Lupiáñez-Villanueva F, Torán Monserrat P. Cost-utility analysis of a consensus and evidence-based medication review to optimize and potentially reduce psychotropic drug prescription in institutionalized dementia patients. BMC Geriatr. 2021;21(1):327. doi:10.1186/s12877-021-02287-7

35. Massot Mesquida M, Tristany Casas M, Franzi Sisó A, García Muñoz I, Hernández Vian Ó, Torán Monserrat P. Consensus and evidence-based medication review to optimize and potentially reduce psychotropic drug prescription in institutionalized dementia patients. BMC Geriatr. 2019;19(1):7. doi:10.1186/s12877-018-1015-9

36. Maust DT, Kim HM, Seyfried LS, Chiang C, Kavanagh J, Schneider LS, et al. Antipsychotics, other psychotropics, and the risk of death in patients with dementia: number needed to harm. JAMA Psychiatry. 2015;72(5):438-45. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.3018

37. McInerney BE, Cross AJ, Alderman CP, Bhat R, Boyd CM, Brandt N, et al. Top 10 signs and symptoms of psychotropic adverse drug events to monitor in residents of long-

term care facilities. J Am Med Dir Assoc. 2024;25(9):105118. doi:10.1016/j.jamda.2024.105118

38. Möhler R, Richter T, Köpke S, Meyer G. Interventions for preventing and reducing the use of physical restraints for older people in all long-term care settings. Cochrane Database Syst Rev. 2023;7(7):CD007546. doi:10.1002/14651858.CD007546.pub3

39. Muñiz R, Pérez-Wehbe AI, Couto F, Pérez M, Ramírez N, López A, et al. The "CHROME criteria": tool to optimize and audit prescription quality of psychotropic medications in institutionalized people with dementia. Int Psychogeriatr. 2020;32(3):315-24. doi:10.1017/S104161021900111X

40. National Institute for Health and Care Excellence. Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers. NICE guideline NG97. London: NICE; 2018. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng97

41. O'Mahony D, Cherubini A, Guiteras AR, Denkinger M, Beuscart JB, Onder G, et al. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 3. Eur Geriatr Med. 2023;14(4):625-32. doi:10.1007/s41999-023-00777-y

42. Pérez Díaz J, Ramiro Fariñas D, Aceituno Nieto P, Escudero Martínez J, Bueno López C, Castillo Belmonte AB, et al. Un perfil de las personas mayores en España, 2023. Indicadores estadísticos básicos. Informes Envejecimiento en Red n.º 30. Madrid: CSIC; 2023. Disponible en: https://www.csic.es/sites/default/files/31octubre2023_InformeMayores_0.pdf

43. Pottie K, Thompson W, Davies S, Grenier J, Sadowski CA, Welch V, et al. Deprescribing benzodiazepine receptor agonists: evidence-based clinical practice guideline. Can Fam Physician. 2018;64(5):339-51.

44. Reeve E, Gnjidic D, Long J, Hilmer S. A systematic review of the emerging definition of 'deprescribing' with network analysis: implications for future research and clinical practice. Br J Clin Pharmacol. 2015;80(6):1254-68. doi:10.1111/bcp.12732

45. Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Boletín Oficial del Estado, núm. 192, de 11 de agosto de 2022, p. 117584-621. BOE-A-2022-13580.

46. Richter C, Berg A, Langner H, Meyer G, Köpke S, Balzer K, et al. Effect of person-centred care on antipsychotic drug use in nursing homes (EPCentCare): a cluster-randomised controlled trial. Age Ageing. 2019;48(3):419-25. doi:10.1093/ageing/afz016

47. Rodríguez-Pérez A, Alfaro-Lara ER, Albiñana-Pérez S, Nieto-Martín MD, Díez-Manglano J, Pérez-Guerrero C, et al. Novel tool for deprescribing in chronic patients with multimorbidity: List of Evidence-Based Deprescribing for Chronic Patients criteria. Geriatr Gerontol Int. 2017;17(11):2200-7. doi:10.1111/ggi.13062

48. Sánchez-Soblechero A, Gil M, Rojo JM, Muñiz R, Hoyos-Alonso MC, Olazarán J. Trends of antipsychotic prescribing for people with dementia in Spain. J Alzheimers Dis. 2025;107(1):104-11. doi:10.1177/13872877251359682

49. Schneider LS, Dagerman KS, Insel P. Risk of death with atypical antipsychotic drug treatment for dementia: meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. JAMA. 2005;294(15):1934-43. doi:10.1001/jama.294.15.1934

50. Scott IA, Hilmer SN, Reeve E, Potter K, Le Couteur D, Rigby D, et al. Reducing inappropriate polypharmacy: the process of deprescribing. JAMA Intern Med. 2015;175(5):827-34. doi:10.1001/jamainternmed.2015.0324

51. Seppala LJ, Wermelink AMAT, de Vries M, Ploegmakers KJ, van de Glind EMM, Daams JG, et al. Fall-risk-increasing drugs: a systematic review and meta-analysis: II. Psychotropics. J Am Med Dir Assoc. 2018;19(4):371.e11-371.e17. doi:10.1016/j.jamda.2017.12.098

52. Tannenbaum C, Martin P, Tamblyn R, Benedetti A, Ahmed S. Reduction of inappropriate benzodiazepine prescriptions among older adults through direct patient education: the EMPOWER cluster randomized trial. JAMA Intern Med. 2014;174(6):890-8. doi:10.1001/jamainternmed.2014.949

53. Ubeda A, Ferrándiz ML, Maicas N, Gómez C, Bonet M, Peris JE. Potentially inappropriate prescribing in institutionalised older patients in Spain: the STOPP-START criteria compared with the Beers criteria. Pharm Pract (Granada). 2012;10(2):83-91. doi:10.4321/S1886-36552012000200004

54. Vaismoradi M, Mardani A, Lillo Crespo M, Logan PA, Sak-Dankosky N. An integrative systematic review of nurses' involvement in medication deprescription in long-term healthcare settings for older people. Ther Adv Drug Saf. 2024;15:20420986241289205. doi:10.1177/20420986241289205

55. Van Leeuwen E, Petrovic M, van Driel ML, De Sutter AI, Vander Stichele R, Declercq T, et al. Withdrawal versus continuation of long-term antipsychotic drug use for behavioural and psychological symptoms in older people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2018;3(3):CD007726. doi:10.1002/14651858.CD007726.pub3

56. Weeks WB, Mishra MK, Curto D, Petersen CL, Cano P, Hswen Y, et al. Comparing three methods for reducing psychotropic use in older demented Spanish care home residents. J Am Geriatr Soc. 2019;67(7):1444-53. doi:10.1111/jgs.15855

# Anexos

## Anexo A. Sintaxis completa de las cadenas de búsqueda en PubMed

La búsqueda se ejecutó el 1 de noviembre de 2026 en la interfaz de PubMed. Las cadenas se reproducen tal y como se introdujeron, con los campos [tiab] (título y resumen), [mh] (término MeSH), [pt] (tipo de publicación), [dp] (fecha de publicación) y [la] (idioma).

**Tabla 16.** *Cadenas de búsqueda completas y resultados.*

| Cadena | Sintaxis | Registros |
|---|---|---|
| S1 | (deprescrib*[tiab] OR deprescription[tiab] OR withdrawal[tiab] OR discontinuation[tiab] OR "dose reduction"[tiab]) AND (antipsychotic*[tiab] OR psychotropic*[tiab] OR benzodiazepine*[tiab] OR hypnotic*[tiab]) AND ("nursing home*"[tiab] OR "long-term care"[tiab] OR "care home*"[tiab] OR "residential care"[tiab] OR institutionali*[tiab]) AND (aged[mh] OR elderly[tiab] OR older[tiab]) AND 2014:2026[dp] AND (english[la] OR spanish[la]) | 117 |
| S2 | ("chemical restraint*"[tiab] OR "pharmacological restraint*"[tiab] OR "chemical restraints"[tiab]) AND (aged[mh] OR elderly[tiab] OR older[tiab] OR dementia[tiab]) AND 2014:2026[dp] AND (english[la] OR spanish[la]) | 74 |
| S3 | ("physical restraint*"[tiab] OR "mechanical restraint*"[tiab]) AND ("nursing home*"[tiab] OR "long-term care"[tiab] OR "care home*"[tiab] OR "residential care"[tiab]) AND (prevalence[tiab] OR reduc*[tiab] OR intervention*[tiab] OR review[pt] OR "randomized controlled trial"[pt]) AND 2014:2026[dp] AND (english[la] OR spanish[la]) | 109 |
| S4 | ("potentially inappropriate"[tiab] OR STOPP[tiab] OR "Beers criteria"[tiab] OR STOPPFrail[tiab]) AND ("nursing home*"[tiab] OR "long-term care"[tiab] OR institutionali*[tiab] OR "care home*"[tiab]) AND (psychotropic*[tiab] OR antipsychotic*[tiab] OR benzodiazepine*[tiab] OR polypharmacy[tiab]) AND 2014:2026[dp] AND (english[la] OR spanish[la]) | 252 |
| S5 | (nurs*[tiab]) AND (deprescrib*[tiab] OR "medication review"[tiab] OR "antipsychotic reduction"[tiab] OR "psychotropic reduction"[tiab]) AND ("nursing home*"[tiab] OR "long-term care"[tiab] OR "care home*"[tiab]) AND (dementia[tiab] OR aged[mh]) AND 2014:2026[dp] AND (english[la] OR spanish[la]) | 278 |
| S6 | (Spain[tiab] OR Spanish[tiab] OR España[tiab]) AND ("nursing home*"[tiab] OR "long-term care"[tiab] OR residen*[tiab] OR institutionali*[tiab]) AND (psychotropic*[tiab] OR antipsychotic*[tiab] OR benzodiazepine*[tiab] OR "physical restraint*"[tiab] OR polypharmacy[tiab] OR "inappropriate prescribing"[tiab]) AND (aged[mh] OR elderly[tiab] OR older[tiab]) AND 2014:2026[dp] | 72 |

Fuente: elaboración propia.

## Anexo B. Criterios STOPP versión 3 relacionados con los psicofármacos en personas mayores

Resumen en español de los criterios de la versión 3 de STOPP (O'Mahony et al., 2023; versión española de Delgado-Silveira et al., 2023) que más interesan para detectar los psicofármacos que necesitan una revisión. La letra identifica la sección (A, indicación; B,

cardiovascular; D, sistema nervioso central; K, fármacos que aumentan el riesgo de caídas; M, carga anticolinérgica).

**Tabla 17.** *Criterios STOPP v3 de interés para la revisión de psicofármacos en residencias.*

| Código | Criterio (resumen) | Motivo que aduce el criterio |
|---|---|---|
| A3 | Prescripción duplicada de la misma clase (por ejemplo, dos antipsicóticos) para uso diario | Optimizar la monoterapia antes de añadir un segundo agente |
| B18 | Antipsicóticos a largo plazo con antecedente de enfermedad vascular coronaria, cerebral o periférica | Mayor riesgo de trombosis |
| D1 | Antidepresivos tricíclicos en demencia, glaucoma, trastornos de conducción, prostatismo, estreñimiento, caídas recientes, retención urinaria o hipotensión ortostática | Empeoramiento de esas condiciones |
| D4 | Antipsicóticos con efecto anticolinérgico moderado o marcado en síntomas urinarios por prostatismo o retención previa | Retención urinaria |
| D5 | Antipsicóticos para los SPCD a dosis sin cambios durante más de 3 meses sin revisión | Efectos extrapiramidales, empeoramiento cognitivo y morbimortalidad cardiovascular |
| D8 | Benzodiacepinas durante 4 semanas o más | Sedación prolongada, confusión, alteración del equilibrio, caídas; retirar de forma gradual |
| D9 | Benzodiacepinas para la agitación o los síntomas psicóticos de la demencia | Sin evidencia de eficacia |
| D10 | Benzodiacepinas para el insomnio durante 2 semanas o más | Dependencia, caídas, fracturas |
| D11 | Fármacos Z para el insomnio durante 2 semanas o más | Caídas y fracturas |
| D12 | Antipsicóticos distintos de clozapina o quetiapina en parkinsonismo o demencia con cuerpos de Lewy | Síntomas extrapiramidales graves |
| D13 | Anticolinérgicos para tratar los efectos extrapiramidales de los antipsicóticos | Toxicidad anticolinérgica |
| D14 | Fármacos con efecto anticolinérgico potente en delirium o demencia | Agravamiento del deterioro cognitivo |
| D15 | Antipsicóticos en SPCD durante más de 12 semanas, salvo síntomas graves y fracaso de lo no farmacológico | Ictus e infarto de miocardio |
| D16 | Antipsicóticos como hipnóticos, salvo que el trastorno del sueño se deba a psicosis o a los SPCD | Confusión, hipotensión, efectos extrapiramidales, caídas |
| D21 | Fenotiazinas como primera línea en psicosis o síntomas no cognitivos de la demencia | Sedación y toxicidad antimuscarínica |
| D23 | Levodopa o agonistas dopaminérgicos para el parkinsonismo inducido por antipsicóticos | Cascada de prescripción |
| K1 | Benzodiacepinas en pacientes con caídas recurrentes | Reducen el nivel de conciencia y alteran el equilibrio |
| K2 | Antipsicóticos en pacientes con caídas recurrentes | Parkinsonismo |
| K4 | Fármacos Z en pacientes con caídas recurrentes | Sedación diurna prolongada, ataxia |

| Código | Criterio (resumen) | Motivo que aduce el criterio |
|---|---|---|
| K8 | Antidepresivos en pacientes con caídas recurrentes | Alteración del nivel de conciencia |
| M1 | Dos o más fármacos con propiedades anticolinérgicas de forma simultánea | Toxicidad anticolinérgica acumulada |

Fuente: elaboración propia a partir de O'Mahony et al. (2023) y Delgado-Silveira et al. (2023). SPCD: síntomas psicológicos y conductuales de la demencia.

# Anexo C. Lista de comprobación enfermera para revisar y registrar un psicofármaco pautado a demanda o sin indicación específica

Propuesta de lista de comprobación elaborada a partir de la Instrucción 1/2022, del Acuerdo de acreditación del SAAD de 2022 y de la guía del Defensor del Pueblo de 2026, pensada para incorporarla al registro de administración de cualquier psicofármaco pautado a demanda o sin indicación específica. Rellenarla no presupone que la pauta sea una contención: documenta la revisión que permite decidirlo.

**Tabla 18.** *Lista de comprobación enfermera para la revisión y el registro de un psicofármaco a demanda o sin indicación específica.*

| Elemento que debe constar | Sí / No | Observaciones |
|---|---|---|
| Identificación de la persona y fecha y hora de la administración | | |
| Conducta o situación que motiva la administración, descrita de forma objetiva (qué, cuándo, con quién, intensidad) | | |
| Causas tratables valoradas y descartadas (dolor, infección, estreñimiento, retención, hambre, sed, ruido, soledad) | | |
| Medidas no farmacológicas intentadas antes y su resultado | | |
| Prescripción facultativa individualizada: fármaco, dosis, vía, indicación, síntoma diana, finalidad de la pauta, dosis máxima diaria y fecha de revisión | | |
| Información dada a la persona o a su representante y constancia de su voluntad y preferencias | | |
| Consentimiento explícito para esta situación (no genérico ni diferido) | | |
| Vigilancia realizada tras la administración: nivel de sedación, constantes, deglución, caídas, respuesta observada | | |
| Duración prevista de la pauta y fecha de reevaluación por el equipo | | |

| Elemento que debe constar | Sí / No | Observaciones |
|---|---|---|
| Si la revisión concluye que la finalidad es restrictiva: inclusión en el registro de contenciones del centro y en el listado que se remite a la Fiscalía | | |
| Comunicación en el relevo de turno y en el plan de cuidados | | |

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 15, 19, 29 y 45.